# LXXII. Egészségbiztosítási Alap

Kiss Zsolt
*főigazgató*

P.H

*Budapest, 2020. augusztus „25.”*

Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Törzskönyvi azonosító száma: 328104
Honlapjának címe: www.neak.gov.hu

## Az Egészségbiztosítási Alap 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kt.) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2019. évi költségvetését 2 442 068,2 millió forint bevételi és kiadási főösszeggel határozta meg.

Az E. Alap 2019. évi költségvetési hiánya 107 234,4 millió forint, 2 433 531,3 millió forint bevételi és 2 540 765,7 millió forint kiadási összeg mellett.

## Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása

Az E. Alap bevételi főösszege 2 433 531,3 millió forint, amely az irányzattól 8536,9 millió forinttal, 0,3 százalékkal maradt el.

Az eltérés az irányzattól történő a következő tényezők együttes hatásából ered:

- a járulékbevételek és hozzájárulások (ide értve az egészségügyi hozzájárulást is) – kivéve a késedelmi pótlék és bírság – 10 505,0 millió forinttal, 0,6 százalékkal,
- a késedelmi pótlék és bírság 558,2 millió forinttal, 16,2 százalékkal

alacsonyabb;

- az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 973,4 millió forinttal, 0,6 százalékkal,
- a működési célú bevételek 1532,8 millió forinttal;
- a vagyongazdálkodás bevétele 20,1 millió forinttal

magasabb az irányzatnál.

Az E. Alap bevételei összességében az előzőévhez képest 83 399,1 millió forinttal, 3,5 százalékkal növekedtek az alábbi tényezők együttes hatásaként:

- a 2019 januárjától megszűnt egészségügyi hozzájárulás 132 750,0 millió forinttal, 75,9 százalékkal
- a költségvetési hozzájárulások 93 407,2 millió forinttal, 17,4 százalékkal,
- az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 17 883,1 millió forinttal, 9,5 százalékkal,

csökkent;

- a szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék az alap közötti, módosított megosztási szabályok miatt 218 486,0 millió forinttal, 44,1 százalékkal
- a biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevételek 102 390,7 millió forinttal, 11,5 százalékkal,
- az egyéb járulékok és hozzájárulások 5292,9 millió forinttal, 8,5 százalékkal,
- a késedelmi pótlék és bírság 588,8 millió forinttal, 25,7 százalékkal,
- a vagyongazdálkodásból származó bevételek 17,6 millió forinttal, 102,9 százalékkal
- a működési célú bevételek 663,2 millió forinttal, 51,4 százalékkal,

növekedett.

## Járulékbevételek és hozzájárulások

A bevételek alakulását döntő mértékben meghatározó járulékbevételekből, hozzájárulásokból és késedelmi pótlékból 2019. évben 1 818 426,8 millió forint befizetés származott, amely az előirányzatnál (1 829 490,0 millió forint) 11 063,2 millió forinttal alacsonyabb. A 2018. évi tényadathoz viszonyított növekedés 194 008,4 millió forint, amelyet az alább ismertetett változások okoztak.

Az E. Alapot megillető szociális hozzájárulási adóbevétel és munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek együttes tényadata 713 844,4 millió forint, amely az összes bevétel 29,3 százalékát jelenti. A teljesülés az előirányzattól 36 639,8 millió forinttal, 4,9 százalékkal maradt el, az előző évi tényszámot 218 486,0 millió forinttal, 44,1 százalékkal haladta meg. A csökkenés meghatározó tényezője, hogy 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 2,0 százalékponttal mérséklődött (19,5 százalékról 17,5 százalékra).

A bevételek közül 40,8 százalékot képviselő biztosított egészségbiztosítási járulékbevétel alcím teljesítési adata 992 266,1 millió forint, ezzel az előirányzatot 7290,1 millió forinttal 0,7 százalékkal, míg az előző évi tényszámot 102 390,7 millió forinttal, 11,5 százalékkal haladta meg. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke az előző évhez képest változatlan.

Az egyéb járulékokból és hozzájárulásokból együttesen 67 385,6 millió forint befizetés teljesült, amely az előirányzatnál 898,1 millió forinttal, 1,4 százalékkal, a 2018. évi befizetéseknél 5292,9 millió forinttal, 8,5 százalékkal több.

Az alcímen belül az egyes előirányzatok teljesítései a következőképpen alakultak:

Az egészségügyi szolgáltatási járulék bevétele 731,9 millió forint, ami az előirányzattól 1203,8 millió forinttal, 3,6 százalékkal maradt el, az előző évi tényszámot 1061,1 millió forinttal, 3,4 százalékkal haladta meg.

A megállapodás alapján fizetett járuléka 293,2 millió forint, amely az előirányzattól 21,8 millió forinttal, 6,9 százalékkal maradt el, az előző évi tényszámot 7,8 millió forinttal, 2,7 százalékkal haladta meg.

A munkáltatói táppénz hozzájárulás bevétele 342,3 millió forint, amely az előirányzatot 2074,2 millió forinttal, 6,3 százalékkal, az előző évi tényszámot 4203,8 millió forinttal, 13,7 százalékkal haladta meg.

Az egyszersített foglalkoztatás utáni közteher jogcím éves összege 242,6 millió forint, teljesítése 292,1 millió forint, mely az előirányzatnál 49,5 millió forinttal, az előző évi tényszámnál 20,2 millió forinttal több.

Az egészségügyi hozzájárulás teljesítése 42 048,6 mforint, az előirányzatnál 17 946,6 millió forinttal, 74,5 százalékkal több, az előző évi tényszámnál 132 750,0 millió forinttal, 75,9 százalékkal kevesebb.

A késedelmi pótlék, bírság összege 2884,1 millió Ft, amely az előirányzattól 558,2 millió forinttal, 16,2 százalékkal maradt el, a 2018. évi tényszámot 588,8 millió forinttal, 25,7 százalékkal haladta meg.

## Költségvetési hozzájárulások

A költségvetési hozzájárulások éves bevétele 446,2 millió forint, amely az előző évi tényszámnál 93 407,2 millió forinttal alacsonyabb.
Az alcímen belül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás – 5400,0 millió forint – az előirányzat szintjén teljesült.

A 2019. évben a központi költségvetés az úgynevezett nemzeti kockázatközösség keretében havonta 7 320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetett – járulék címen átvett pénzeszköz címen a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (5) bekezdésében meghatározott személyek után (pl.: nyugdíjasok, GYED-ben részesülők, fogvatartottak, szociálisan rászorulók, stb,), évenkénti összeg – azaz előirányzat szerinti – 437 496,6 millió forint volt.

## Ellátások fedezetéül szolgáló egyéb bevételek

Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcímen a 2019. évben befizetett bevételek együttes összege 170 220,2 millió forint volt, amely az előirányzat összegét 973,4 millió forinttal, 0,6 százalékkal haladta meg.

Az alcímen belül az egyes előirányzatok teljesítései a következőképpen alakultak:
A terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 599,2 millió forint, amely az előirányzatot 74,2 millió forinttal, 14,1 százalékkal haladta meg, az előző évi tényszámtól 9,7 millió forinttal, 1,6 százalékkal maradt el.

A baseti és egyéb kártérítési megtérítésekből 1794,5 millió forint bevétel keletkezett, amely az előirányzatot 929,9 millió forinttal, 14,8 százalékkal, a 2018. évi tényadatot 424,9 millió forinttal, 6,3 százalékkal haladta meg. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás keretében az E. Alapot megillető megtérítés összege 4748,0 millió forint volt.

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek címen 2189,5 millió forint befizetés történt, ami az előirányzattól 635,6 millió forinttal, 40,9 százalékkal, az előző évi tényszámtól 38,0 millió forinttal, 1,8 százalékkal több.

A gyógyszergyártók és gyógyszerforgalmazók befizetéséből 92 117,7 millió forint bevétel keletkezett, amely az előirányzatot 10 417,4 millió forinttal, 12,8 százalékkal, az előző évi tényszámot 3902,0 millió forinttal, 4,4 százalékkal haladta meg. A változásban szerepet játszott a megnövekedett gyógyszertámogatás és az így százalékos gyártói befizetés növekedése, illetve a gyógyszerismeretek után fizetendő díj és a támogatásvolumen szerződések alapján fizetett befizetések emelkedése.

Az E. Alapot 2019. évben 30 959,1 millió forint a gyógyszergyártókkal kötött szerződések (pl. támogatásvolumen) révén, valamint 61 158,6 millió forint a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos befizetések alapján illette meg. A gyógyszerforgalmazás utáni befizetések jogcím magában foglalja a 20,0 százalékos gyártói, 10,0 százalékos kiegészítő gyártói (spanyol modell) befizetési kötelezettségeken túl a gyógyszerértékesítések után történő valamint a nagykereskedői befizetéseket is.

A nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítéséből származó bevétel 7324,7 millió forint, amely az előirányzatnál 2739,7 millió forinttal, az előző évi befizetés összegénél 1018,5 millió forinttal több.

A jogcímek magukban foglalják az EGT tagállamokban kiállított E jel formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet a benyújtott költségigények alapján térítenek meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére a külföldi biztosítók (külföldiek magyarországi ellátása közösségi szabályok alapján). A magyar-montenegrói, magyar-bosnyák, magyar-szerb és magyar-albán egyezmények alapján magyarországi ellátások kifizetése a montenegrói, bosnyák, szerb és albán biztosítottak magyarországi sürgősségi ellátásait tartalmazza.

Az egészségügyi szolgáltatók visszafizetéséből 459,8 millió forint bevétel keletkezett, amely az előirányzatnál 290,2 millió forinttal kevesebb, a 2018. évi teljesítésnél 15,3 millió forinttal több. A visszafizetésből 35,4 millió forint kapcsolódott a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekhez, míg 124,4 millió forint az egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetéséből származott az E. Alapot.

A baleseti adóból 7941,4 millió forint befizetés történt, amely az előirányzatnál 9026,6 millió forinttal, 53,2 százalékkal, az előző évi tényszámnál 35 393,7 millió forinttal, 81,7 százalékkal kevesebb. A jelentős eltérést a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó baleseti adó megszüntetése okozza. Helyére 2019. január 1-jétől a biztosítási adó veszi át.

A népegészségügyi termékadó címen 52 693,4 millió forint bevétele származott az E. Alapnak, amely az előirányzathoz viszonyítva 4506,6 millió forinttal 7,9 százalékkal kevesebb, az előző évi tényszámnál 12 121,6 millió forinttal, 29,9 százalékkal több.

## Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás bevételi előirányzata 15,0 millió forint volt, ténylegesen 35,1 millió forint realizálódott. A jelentős bevétel növekedést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 100. §-a alapján köztartozás fejében történő átvétel és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére készpénzes értékesítésre vagy azzal egyenértékű további hasznosításra átadott vagyonelemek értékesítéséből származó bevétel növekedése okozta.

M ködési célú bevételek

A NEAK 2019. évi eredeti bevételi el irányzata 419,8 millió forint, amely összeg év közb n 1517,3 millió forinttal emelkedett, így a módosított el irányzat 1937,1 millió forint.
A teljesítési adat 1952,6 millió forint, amely 1532,8 millió forinttal több, mint az eredeti el irányzat.

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi törvényi eredeti el irányzat | 2019. évi módosított el irányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi telj. az eredeti el irányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|
| Egészségbiztosítási költségvetési szervek bevételei | 1 289,4 | 419,8 | 1 937,1 | 1 952,6 | 465,1 |
| M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l | 614,4 | | 1 025,1 | 1 025,1 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l | | | 260,2 | 260,2 | |
| Közhatalmi bevételek | 291,3 | 254,6 | 323,5 | 338,9 | 133,1 |
| M ködési bevételek | 181,2 | 165,2 | 196,3 | 196,4 | 118,9 |
| Felhalmozási bevételek | 1,2 | | | | |
| M ködési célú átvett pénzeszközök | 164,7 | | 111,6 | 111,6 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 36,6 | | 20,4 | 20,4 | |

Többletbevétel a m ködési bevételeknél, a m ködési célú támogatások államháztartáson belülr l, a m ködési célú átvett pénzeszközöknél, továbbá a felhalmozási célú átvett pénzeszközök címsorokon keletkezett.

A költségvetési bevételek eredeti el irányzata – amely tartalmazza a közhatalmi és m ködési bevételeket – 419,8 millió forint. A módosított el irányzat 519,8 millió forint, amely a m ködési bevétel 100,0 millió forint összeg többletbevételek el irányzatosításából adódott.

A NEAK 535,3 millió forint összeg közhatalmi és m ködési bevételt realizált. A közhatalmi bevétel 63,3 százaléka – 338,9 millió forint – igazgatási szolgáltatási díj jogcímen keletkezett.

A 196,4 millió forint m ködési bevételek a beszámolási id szakban az alábbi jelent sebb tételekb l tev dtek össze:

- készletértékesítés ellenértéke 1,2 millió forint,
- gépi adatszolgáltatás nyújtása 100,6 millió forint,
- a kiszámlázott általános forgalmi adó 30,3 millió forint,
- továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) 5,1 millió forint,

- helyiség bérbeadásából származó díjak 20,9 millió forint,
- oktatás, üdültetés, dolgozóknak nyújtott szolgáltatás 1,5 millió forint,
- gépkocsi használat, mobil telefon túllépés, és egyéb bevétel 3,7 millió forint,
- kártérítések 0,2 millió forint,
- egyéb működési bevétel 25,8 millió forint,
- realizált árfolyam nyereség és kamatjellegű bevétel 0,7 millió forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 025,1 millió forint.

Támogatásértékű bevétel
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának finanszírozására jóváhagyott 1,5 millió forint,
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény bevezetésével kapcsolatos kiadásokra jóváhagyott 346,0 millió forint,
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8) PM rendelet alapján jóváhagyott 0,2 millió forint munkáltatói kifizetések támogatásából,
- EFOP 1.9.6., KÖFOP 00043 SZAKINT, KÖFOP 00051 projektekre 677,4 millió forint támogatásából,

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről irányzati soron 260,2 millió teljesítés történt, melyből
- EFOP 1.9.6.-16-2017-0001, a KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-00043, továbbá a KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projektekre befolyt 245,2 millió forint támogatási összegből, valamint,
- A Kormány 1716/2019.(XII.17) Korm. határozat alapján az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges források biztosítására, elsősorban a házasságkötést követően szükséges okmányok kiadásával, összefüggő eljárások egyszerűsítésére, valamint az újszülöttek okmányainak kiadásával összefüggő eljárások egyszerűsítésére, elektronizálására biztosított 15,0 millió forint .

A 2019. évi teljesítés (1952,6 millió forint) és a módosított elirányzat (1937,1 millió forint) 15,5 millió forint összeg eltérését a 100,0 millió forint feletti bevételi többlet engedélyeztetésének elmaradása okozta.

A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 111,6 millió forint, amely az EURIPID projekt támogatásával összefüggő bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 20,4 millió forint, amely a dolgozóknak korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülése (14,8 millió forint), valamint az EURIPID projektre különféle országok tagdíjbefizetése (5,6 millió forint).

## Az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak alakulása

Az E. Alap 2019. évi kiadási összege 2 540 765,7 millió forint, amely az eredeti előirányzatnál 98 697,5 millió forinttal, 4,0 százalékkal, az előző évi kiadásnál 106 645,6 millió forinttal, 4,4 százalékkal magasabb.

## Pénzbeli ellátások

A Kt. az E. Alap pénzbeli ellátásaira vonatkozóan 680 532,2 millió forintot irányzott elő. A tárgyévi teljesítés 688 833,8 millió forint volt, amely az előirányzatot 8301,6 millió forinttal, 1,2 százalékkal, az előző évi teljesítést pedig 38 734,1 millió forinttal haladta meg.

A csecsemőgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély kiadás az előirányzat 2019. évre 68 235,5 millió forint volt, a kifizetés 66 157,7 millió forintban teljesült. Az előirányzathoz viszonyított 1643,8 millió forintos kiadás elmaradást (2,4 százalék) az igénybevevők havi átlagos számának, valamint a segélyezésben töltött napok számának vártnál alacsonyabb szintalakulása okozta.

A 2019. évi költségvetésben a táppénz együttes irányzata 126 128,0 millió forint, a táppénzre fordított kiadás ezt (5,4 százalékkal) meghaladva 132 904,7 millió forint összegben teljesült.

Az előző évi kiadáshoz (116 912,0 millió forint) viszonyított 15 992,7 millió forintos (13,7 százalék) kiadás növekedés összetevői a következők:

- a táppénzes napok száma 2019. évben az előző évhez képest több;
- az egy napra jutó táppénzkiadás az előző évhez képest 15,6 százalékkal növekedett;
- a táppénzesek napi átlagos száma a táppénzes napok növekedésének megfelelően nőtt.

2019-ben a táppénz maximuma 9 933 forint/nap (a minimálbér – 149 000 forint – kétszeresének harmincad része) volt, ez 2018. évben 9 200 forint/nap összeget jelentett.

A 132 904,7 millió forint kiadási összegből a baseti táppénzre fordított kiadás 14 367,9 millió forint. A baseti táppénz kiadás az előirányzatot 917,9 millió forinttal, 6,8 százalékkal haladta meg. A baseti táppénz aránya az összes táppénzkiadáson belül 10,8 százalék, ami 0,3 százalékkal több az előző évi aránynál. Az előirányzathoz viszonyított kiadásnövekedés az egy baseti táppénzes napra jutó kiadás növekedése és a baseti táppénzes napok számának százalékos emelkedése következtében jött létre.

Az összes táppénzes kiadásból a gyermekápolási táppénz 6280,4 millió forint, amely az előirányzatnál 102,4 millió forinttal, 1,7 százalékkal több. A gyermekápolási táppénz aránya – az előző évhez hasonlóan – az összes táppénzkiadáson belül 4,7 százalék. A gyermekápolási táppénzkiadásban a – GYED Extra rendelkezésének köszönően – a GYED mellett munkát végzők érintetti létszáma elérte a 34,1 ezer főt, akik 2 éven aluli gyermek mellett végeznek keresőtevékenységet. A gyermek 3 éves kora alatt a szülő 84 naptári napra lehet jogosult gyermekápolási táppénzre.

A betegséggel kapcsolatos segélyekkel összefüggő egyszeri segély éves teljesítése 450,0 millió forint, ami megegyezik – a korábbi évek gyakorlata alapján a megyei kormányhivatalok között felosztásra kerülő – előirányzattal.

2019. évben országosan 28 421 db segélykérelem érkezett. Az előző évről áthozott, el nem bírált kérelmekkel együtt a kérelmek száma 31 720 volt, 22 662 esetben teljesítésre került. Az egy főre jutó segély összegének átlaga országosan 19 857 forint volt.

A kártérítési járadék 2019. évi tényadata 725,2 millió forint, ami szinte megegyezik az előirányzattal (725,0 millió forint). Kártérítési járadékban havonta átlagosan 2 039 fő részesült, 145 fővel kevesebb, mint 2018. évben. Több éve tartó trend az ellátásban részesülők számának csökkenése. Az egy főre jutó ellátás havi átlagos összege 29 637 forint, a növekedés mértéke az előző évhez képest 302,7 forint, 1,0 százalék.

Baleseti járadék címen 8098,2 millió forint került kifizetésre, amely az előirányzatnál 1,8 millió forinttal, az előző évi kiadásnál 2,2 millió forinttal kevesebb. A járadék összege 2019 januárjától a nyugdíj emelés mértékének megfelelően 2,7 százalékkal emelkedett, majd 2019 novemberében 0,7 százalékos kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjemelésre irányadó szabályok szerint. A kiadás tartalmazza a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások utáni jogszerű juttatásról szóló 237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az ellátottak részére kifizetett 54,6 millió forint egyszeri juttatás összegét is. Baleseti járadékban átlagosan, havonta 22 972 fő részesült, amely 786 fővel kevesebb, mint az előző évben. Az egy főre jutó ellátás havi átlagos összege 29 179,1 forint, a növekedés mértéke az előző évhez képest 942,3 forint, 3,3 százalék.

A gyermekgondozási díj kiadásának irányzata 190 127,3 millió forint, a teljesítés 197 409,6 millió forint volt, amely az előirányzatnál 7282,3 millió forinttal, 3,8 százalékkal több.

A minimálbér emelkedésén túl továbbra is hatással volt a gyermekgondozási díj kiadására, hogy a csecsemőgondozási díj lejártát követően, a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban lehet dolgozni, így egyre több apa veszi igénybe a GYED-et. Míg 2018-ban 17 777 apa vette igénybe a GYED-et, addig 2019-ben már 21 936 fő, vagyis folyamatosan növekszik a GYED-et igénybe vevő apák száma (2018-ban a GYED mellett munkát végző apák száma 12 295 fő volt, addig ez a szám 2019-re 14 805 főre emelkedett).

Az előző évhez viszonyított kiadásnövekedést a következő tényezők együttesen okozták:

- az igénybevevők átlagos száma nőtt;
- az egy napra jutó kiadás emelkedett; a kiadások emelkedésében közrejátszott a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló átlagkereset növekedése, és a minimálbér emelkedése következtében megnőtt a GYED maximális összege (2018. évben 193 200 forint, 2019-ben 208 600 forint).

Méltányossági jogkörben engedélyezhető valamennyi pénzbeli ellátásra 200,0 millió forint keret állt rendelkezésre a 2019. évben, mely összeg a megyei kormányhivatalok között került felosztásra.

A méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások 200,0 millió forintos előirányzatából összesen 149,7 millió forint került kifizetésre. Ebből

- méltányosságból engedélyezhető táppénzre 39,7 millió forint (mely az összes kiadás 26,6 százaléka).
- gyermekápolási táppénz címén 18,1 millió forint, az összes költség 12,0 százaléka került kifizetésre,
- a csecsemőgondozási díj a kiadás 33,9 százaléka, 50,8 millió forint volt,

- 41,1 millió forint gyermekgondozási díjra került kifizetésre, mely az összes kiadás 27,5 százaléka.

A 2018. évi kiadásokhoz viszonyítva, 2019. évben méltányosságból engedélyezhet pénzbeli ellátásokra fordított összeg 15,9 millió forinttal volt több.

Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén elutasításra kerültek azon kérelmek, melyekben a kérelmező nem volt biztosított, illetve nagyon rövid biztosítási idővel rendelkezett. Táppénz iránti kérelmek esetében több a várandós kismamák, továbbá a daganatos megbetegedésben szenvedő részére került megállapításra az ellátás. A gyermekápolási táppénzt a szülők túlnyomó többségben a daganatos betegségben szenvedő gyermekek kórházi és otthoni ápolására hivatkozva kérik, de egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyermek egyéb, rövidebb lefolyású megbetegedése idejére is kérelmezi a szülő a gyermekápolási táppénz méltányosságból történő engedélyezését, mert a jogszabályban meghatározott, gyermek életkorához kötött időtartamot kimerítette, vagy a gyermek a 12. életévét már betöltötte.

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások irányzata 286 766,4 millió forint, a teljesítés 282 654,4 millió forint volt, ami az irányzattól 1,4 százalékkal maradt el. Az ellátások összege 2019 januárjától a nyugdíj emelés mértékének megfelelően, 2,7 százalékkal emelkedett, majd 2019 novemberében 0,7 százalékos kiegészít emelés valósult meg, a kiegészít nyugdíjemelésre irányadó szabályok szerint. A kiadás teljesítés magában foglalja az ellátottak részére a Korm. rendelet szerint kifizetett (az előző évről áthúzódó elszámolást is tartalmazó) 5161,4 millió forint egyszeri juttatás összegét is. Az előző évhez viszonyított 1,4 százalékos kiadásmérséklődést – elsősorban – az igénybevevők átlagos számának csökkenése és az ellátás emelés együttes hatása okozta. Különös méltányolást érdemlő körülmény esetén rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 150,0 millió forint keret állt rendelkezésre a 2019. évben, melyből 128,0 millió forint került kifizetésre. Az ellátás átlagos létszáma 246 fő/hónap volt.

## Természetbeni ellátások kiadásai

A természetbeni ellátások eredeti irányzata 1 740 363,0 millió forint, a teljesítés 1 826 332,5 millió forint volt, amely a törvényi irányzatot 4,9 százalékkal (85 969,5 millió forinttal) haladta meg. Az előző évhez képest az emelkedés 64 283,1 millió forint, 3,6 százalék.

## Gyógyító-megelőző ellátások kiadása

A gyógyító-megelőző ellátások eredeti irányzata 1 273 763,5 millió forint, a teljesítés 1 340 689,5 millió forint volt, amely a törvényi irányzatot 5,3 százalékkal (66 926,0 millió forinttal) haladta meg. Az előző évhez képest az emelkedés 34 358,8 millió forint, 2,6 százalék.

A Kt. 15. § (2) bekezdése szerint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek eredeti irányzatai együttesen 3000,0 millió forintot tartalmaztak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

A Kt. 16. §-a alapján a természetbeni ellátások kerete belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra rendelkezésre álló 2611,3 millió forint, majd az évközi forrás-átcsoportosításokat követően rendelkezésre álló 2905,3 millió forint terhére az éves felhasználás 2905,0 millió forint volt.

A Kt. a jogcímcsoport előirányzatait nem módosította, ugyanakkor miniszteri hatáskörben év közben többirányú előirányzat-átcsoportosítás is történt, valamint együttesen 66 946,6 millió forint külső forrás bevonásra is sor került. Ennek eredményeképpen a jogcímcsoport előirányzata 1 340 710,1 millió forintra emelkedett.

A jogcímcsoport 2019. évi kiemelt finanszírozási ügyei az alábbiak:

Sztereotaxiás sugárterápia finanszírozása
A modern sztereotaxiás sugárterápia eljárás a daganat alakjához, kiterjedéséhez tökéletesen illeszkedő kezelést tesz lehetővé, egyéb daganatos indikáción túli elváltozások kezelésére is alkalmas, valamint a kevésbé sugár-érzékeny daganatok esetében is hatásos. Nagyfokú precizitással rendelkező kezelés, melynek alkalmazása a modern kor egészségügyi rendszerének elvárt és egyúttal szükséges eleme is, mivel akár önmaga is képes teljes tumor-mentességet biztosítani.
Ezen eljárás közfinanszírozásával kapcsolatos – 2018. október 1-jétől hatályos – intézkedések 2019. évi fedezetének biztosítása érdekében az 2018/2518. (X. 17.) Korm. határozat az Összevont szakellátás jogcím előirányzatát 632,3 millió forinttal megemelte, valamint a gyógyító-megelőző ellátás céltartaléka jogcím terhére 638,0 millió forintot csoportosított át a jogcím javára.

Sürgősségi ellátási rendszer fejlesztése
A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (a továbbiakban: MSTR) bevezetésével elérni kívánt cél a teljes magyar sürgősségi ellátórendszerben a biztonságos és költséghatékony betegellátás és egy egységes szemlélettel működő, gördülékeny rendszer biztosítása. Az MSTR olyan nemzetközi tapasztalatokra és evidenciákra épülő, országosan egységes, megbízható beteg megítélési és betegirányítási rendszert biztosít, amely megteremti az átlátható, betegbiztonsági és minőségbiztosítási normáknak és kritériumoknak megfelelő kódolást és adatkezelési lehetőséget.

Az MSTR egységes bevezetésével egyidejűleg a sürgősségi osztályok finanszírozásának javítása érdekében a járóbeteg-szakellátás terhére új OENO kód (11030 és 11031) is bevezetésre került, amelyet kizárólag a MSTR rendszert alkalmazó sürgősségi osztályok jelenthetnek a NEAK-nak. Az új finanszírozási elem bevezetésének célja az volt, hogy ösztönzőleg hasson az egységes triázs rendszer alkalmazására, amely a sürgősségi ellátások kiemelt költségéhez, valamint a folyamatos rendelkezésre álláshoz biztosítja a fedezetet.

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (a továbbiakban: ORFI) reumatológiai és immunológiai területen országos hatáskörrel akut betegellátást végez, ezért tevékenységét szükséges volt országos hatáskörű akut ellátásnak minősíteni. Ezzel az intézmény havi 5,2 millió forint fix összegű díjra lett jogosult speciális akut ellátási centrum működtetése címén.

A fenti intézkedések 8 havi költségvetési fedezetének (ORFI fixdíj esetében 12 hónap) biztosítása érdekében az 1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozat az összevont szakellátás előirányzatát 627,1 millió forinttal emelte meg (ebből 517,9 millió forint a járóbeteg-szakellátás előirányzatán, 109,2 millió forint az aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatán realizálódott).

M vesekezelés, betegszállítás, gyermekszorzó 10,0 százalék emelése

A Kormány a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet kihirdetésével, valamint a 1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozat közzétételével a gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére együttesen 9800,0 millió forint irányzat-átcsoportosításáról döntött, az alábbiak szerint:

- A betegek egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítása érdekében a M vesekezelés jogcím előirányzata 2300,0 millió forinttal emelkedett.
- A betegszállítás és orvosi rendelvényhalottszállítás jogcímére történő 2500,0 millió forint összeg átcsoportosításra az ellátás területén kialakult forráshiány enyhítése érdekében került sor.
- Az összevont szakellátásra történő 5000,0 millió forint összegű átcsoportosítás a 14 év alatti ellátottak elszámolásánál alkalmazottrésznak, a 2018. augusztus havi teljesítmények elszámolásától történő további 10,0 százalékos emelésének, az újszülöttek objektív hallásszűrését követő ellátások végzésére kijelölt öt centrum fix díjának, valamint az újszülött-kori objektív hallásszűrés a teljesítmény volumen keret (a továbbiakban: TVK) mentesítésének 2019. évi többletforrásigénye miatt volt szükséges. Az átcsoportosított összegből 1200,0 millió forint a járóbeteg-szakellátás, míg 3800,0 millió forint az aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatát növelte.

Évközi előirányzat átcsoportosítások és emelések:

Háziorvosi indikátorrendszer

A háziorvosi indikátorrendszer a háziorvosi szolgálatok finanszírozási elemei közül az az elem, melynek elsődleges célja a praxisok szakmai szabályok mentén történő ösztönzése. Nemzetközi tapasztalatok alapján a finanszírozási ösztönző elemek akkor érnek el valódi hatást, ha az adott finanszírozási forma aránya a teljes finanszírozási összegből legalább 10,0 százalékos. Az indikátorrendszer 2018. évi 3,8 százalékos részaránya ilyen formában nem tudta megfelelő hatékonysággal kifejteni ösztönző hatását. A háziorvosi indikátorrendszerre fordított 4800,0 millió forint összeg éves keret – a praxisfinanszírozás kasszáról történő 2500,0 millió forint összeg fejezeti hatáskörű átcsoportosítással - 7300,0 millió forintra módosult a jogcímen belüli részarány így (az előző évi 3,8 százalékról) 5,2 százalékra emelkedett.

Vastag- és végbélszűrés

A népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűrés második lépcsőjeként megvalósuló kolonoszkópiás vizsgálatok és kapcsolódó beavatkozások finanszírozásával kapcsolatos intézkedések célja a népegészségügyi vastag- és végbélszűrés minimumfeltételeinek megteremtése, a szövettani mintavételi vizsgálatokra vonatkozóan 5 új OENO bevezetése és ezek TVK mentesen történő elszámolásának lehetősége volt.

A megjelölt célok finanszírozásához szükséges 6 milliárd forint – a Kt. felhatalmazása alapján miniszteri hatáskörben összevont szakellátás jogcímre (ezen belül a járóbeteg-szakellátás előirányzatára) 492,9 millió forint került átcsoportosításra a népegészségügy fejlesztése jogcímen rendelkezésre álló 1713,3 millió forint terhére.

Egészségügyi szakdolgozók és nővérek béremelése

Az egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók és nem egészségügyi felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére 2019. november 1-jével esedékes 8,0 százalékos szakdolgozói béremelés 2019. július 1-jére kerülő előrehozásra.

Ezzel egyidejleg az állami, a helyi önkormányzati, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végz szervezet tulajdonában és fenntartásában állón vés szolgáltató által foglalkoztatott területi- és iskolavéd k is bekerültek a szakdolgozói bértábla hatálya alá így július 1. napjától rájuk is a szakdolgozói bértáblában meghatározott alapilletmények vonatkoznak. A szakdolgozók és véd k béremeléséhez szükséges intézkedés 2019. évre számított költségigénye 13 903,2 millió forint volt, amely az egyes fokozatok közötti el relépés, illetve esetlegesen új belép miatt megemelked bérigény fedezetére szolgált és tartalmazta az emelt bér szerinti mozgóbér elemek fedezetét, valamint a 7,0 százalékos tartalék elkülönítését is.

Tekintettel azonban arra, hogy az eredetileg nem tervezett béremelés fedezetére 1993,4 millió forint a célel irányzatok jogcímen belül már rendelkezésre állt, ebb l a véd n i alapbérbe beszámítandó véd i kiegészít pótlék béremeléssel érintett szakra vetített 729,2 millió forint többletfedezetét a véd i jogcím el irányzata már szintén tartalmazta, ezért a béremelés tényleges többletforrásigénye a 2019. évre összesen 11 180,6 millió forint összegben került meghatározásra.

A béremelés eljárási szabályai az 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendeletben kerültek kihirdetésre, míg a pénzügyi fedezetet az 1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat biztosította a célel irányzatok jogcímen belül az egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelése el irányzatának 11 180,6 millió forint összeggel történ emelésével.

Háziorvosi és fogorvosi pályázatok
A célel irányzatok jogcímen belül a 2019. évben 1250,0 millió forint állt rendelkezésre a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzet betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlás támogatására.

A pályázati kiírások értelmében 2019. október 15-ig volt lehet ségük a házi- és fogorvosoknak a pályázatok benyújtására. A pályázat iránt érdekl dök és a nyertes pályázatok jelent s számára tekintettel 476,0 millió forint, a véd i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcímr l átcsoportosításra került – miniszteri hatáskörben – a célel irányzatok jogcímre.

A méltányossági eszköz / eljárás
A 2019. költségvetési évben a célel irányzatok jogcímen belül a méltányossági alapon történ térítések 2611,3 millió forintos el irányzatából az eszközök és eljárások finanszírozására 1283,4 millió forint került év elején elkülönítésre.

A méltányossági eljárás lefolytatására akkor kerül sor, ha a társadalombiztosítási finanszírozásba be nem fogadott, vagy a befogadott eljárást/beavatkozást kérelmez a biztosított. Az egészségügyi szolgáltatások terén folyamatosan jelennek meg az innovatív technológiák, az orvostudomány gyors fejl dése, a technológiai lehet ségek kiszélesedése egyre korszerbb gyógyítási módszereket teremt.

A 2019. év második felében jelent sen megnövekedett kérelmek számára tekintettel – ezen hatáskörben – a fiatal szakorvosok támogatási sorról 300,0 millió forint került átcsoportosításra a méltányossági alapon történ térítések el irányzati sorra.

Traumatológiai fixdíj emelése

Az ellátó rendszeren belül a sürgősségi jellegű beavatkozások esetében, így a traumatológia, és érsebészeti ellátásban, a megfelelő időn belüli hozzáférés és a magas szintű technikai és szakmai ellátás biztosítása (centrumok kialakítása) alapvető feladat. Ezért vált sürgőssé az ellátó rendszer strukturális átalakítása, azt ezt követő finanszírozás átgondolása és a humán erőforrás kapacitások áttekintése.

Kiemelt finanszírozási feladat – az érsebészet ambuláns és fekvőbeteg ellátás mellett – a traumatológia szakma finanszírozási helyzetének javítása. A traumatológiai ellátó hálózatban a személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében a fix díjak 2019. évi emelését követően, illetve a 2020. január havi teljesítmények elszámolásától kezdődően a traumatológiai kódok emelt finanszírozásáról született döntés. A 30/2019. (XII. 4.) EMMI rendelet alapján módosult az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 16. számú melléklete, melyben a traumatológiai ellátások finanszírozási díjai emelkedtek. Az emelés összesen 47 szolgáltatót és több, mint 116 ezer betegellátási eseményt érintett évente. Az emelésnek köszönhetően az eddigi 40 000,0 millió forint helyett 60 000,0 millió forint áll rendelkezésre éves szinten az ellátásokra. A finanszírozás emelése két módon történt: egyrészt a traumatológiai ellátások területén a 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító szolgáltatók rendelkezésre állási fix összeg díjai emelkedtek, illetve a III. progresszivitási szint megbontásával két új fixdíj is (egyetemi tanszékként működő és országos gyógyintézeti traumatológia) kialakításra került.

A módosító rendelet 2. §-a alapján a megállapított díjakra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2019. szeptember hónaptól jogosultak. A 2019. szeptember – december hónapokra járó traumatológiai fixdíj különbözetek finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében Kormány az 1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozattal az összevont szakellátás jogcím előirányzatát 3392,0 millió forint összeggel megemelte

Fogászati egyszeri, kiegészítő díjazás

A fogászati ellátás finanszírozási helyzetének tágabb javítása érdekében a területi ellátási kötelezettséggel működő szolgálatok és szakrendelések és a területi ellátási kötelezettségen kívüli, közfeladatot ellátó szolgálatok és szakrendelések 2019. december hónapban egyszeri, kiegészítő díjazásában részesültek. A heti 30 órában működtetett szolgálat és szakrendelés esetében egyszeri 1,5 millió forint, alacsonyabb működési idő esetén időarányosan csökkentett díj került kifizetésre. Az intézkedés pénzügyi fedezete – miniszteri hatáskörben – a fogászati ellátás jogcím javára 4440,4 millió forint került csoportosításra a természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport terhére. (A kiutalt összeg 4460,0 millió forint volt.)

Nagyérték gyógyszerfinanszírozás és a Speciális finanszírozású szakellátás

A nagyérték gyógyszerfinanszírozás előirányzata terhére finanszírozott tételes finanszírozású hatóanyagok köre 2018. október 15-től 14 új hatóanyaggal és számos indikációval bővült.

A terápiás paletta kiszélesedése, valamint a terápiák számának növekedése a kezelt betegek számának emelkedésével jár, amely hozzájárult a kiadások növekedéséhez, ahogy az is, hogy az egyedi méltányossági eljáráshoz szükséges adminisztratív akadály elhárulása után az el zetesen prognosztizált betegszám emelkedett. Az uroonkológiai indikációs köre 2018. novembert l kiszélesítésre került, így méltányossági kérelem nélkül hozzáférhetővé vált a nem kissejtes tüdőrákos daganat indikációban.

A speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás előirányzata terhére finanszírozott egyes tételes elszámolás alá es eszközök és nagyérték eljárások vonatkozásában többletfelhasználási igény jelentkezett a tervezettképhez képest. Az összes többlet forrásigény

meghaladta az 1600,0 millió forintot, melynek egyszeri az egyéb eszközök és eljárások vonatkozásában keletkezkasszamaradvány fedezetet biztosított, azonban a vártnál betegellátás további 800,0 millió forint többletforrás bevonásával volt biztosítható.

A jelzett többletforrás igények fedezetét az Kormány az 1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal az összevont szakellátás jogcímen irányzatának 10 116,2 millió forinttal történő megemelésével biztosította (ebből a nagyérték gyógyszerfinanszírozással összefüggő 9316,2 millió forint.)

Mentés

Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) munkatársainak bérét átsorolása érdekében a mentés jogcím javára 1183,5 millió forint átcsoportosítására került sor – miniszteri hatáskörben – a népegészségügy fejezet irányzatán rendelkezésre álló 1210,4 millió forint terhére.

Egészségügyi dolgozók pénzellátását helyettesítő jövedelem-kiegészítése

A célelőirányzatok jogcímen belül az egészségügyi dolgozók pénzellátását helyettesítő jövedelem-kiegészítése előirányzat 2200,0 millió forint összegű – fejezeti hatáskörben – módosítását a nyugellátásokat érintő egyszeri visszamenőleges emelés, a támogatottak 2018-2019. évek között kimutatható közel 9,0 százalékos (a 2017. évhez képest közel 16,0 százalékos) létszámnövekedése, a szociális hozzájárulási adó mértékének 2,0 százalékpontos csökkenése, valamint a legutóbbi kormányzati támogatói engedélyeket követően ideiglenesen megnövekedett visszamenőleges támogatási igények együttes hatásai indokolták.

Kasszasöprés

A Kr 6. §. (4) bekezdése szerinti „A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítás után az egyes szakfeladatokon rendelkezésre álló előirányzat osztható fel és fizethető ki, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.” Az év utolsó előirányzat-átcsoportosítására a december havi finanszírozás, valamint a tervezett hóközi kiutalások figyelembevételével került sor. A gyógyító-megelőző ellátás egyes jogcímein jelentkező előirányzat-maradvány felosztás elveit a NEAK és az EMMI együttesen határozta meg. Az összesen 7375,8 millió forint maradványösszeg felosztásának elvei az alábbiak voltak:

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem: 300,0 millió forint

Az iskolaegészségügyi ellátásban résztvevő szolgáltatók részére a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében 300,0 millió forint kerültfizetésre, tekintettel arra, hogy az iskolaorvosi ellátásban részmunkaidőformában működő szolgáltatók legutóbb 2013. évben részesültek finanszírozási díjemelésben, a teljes munkaidős szolgáltatók pedig 2016-ban. Az iskolaorvosi ellátást nyújtó szolgáltatók bértámogatásban sem részesültek, amely indokolttá tette, hogy a maradvány terhére többletfinanszírozásban részesüljenek.

Fogászati ellátás: 4460,0 millió forint

A Kormány kiemelt célja a fogászati ellátás finanszírozásának rendezése. Ennek érdekében a közfinanszírozott fogorvosi alapellátási szolgáltatók és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek. A 2019. évben minden 30 óránál többet működtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgálat és szakrendelés esetében egyszeri 1,5 millió forint, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díj került kifizetésre. Az összegű egyszeri kiegészítő díjazásként 4460,0 millió forint került kiutalásra

Otthoni szakápolás és otthoni hospice: 1000,0 millió forint
A magas szint betegellátáshoz szükséges dolgozói létszám hosszú távú biztosítása, illetve a feladat ellátásban részt vev szolgálatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében 1000,0 millió forint került kifizetésre.

Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás: 376,2 millió forint
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet értelmében a 2009. április 1. napja után betegszállító járm ként üzembe helyezett betegszállító gépjárművek legfeljebb a gyártás évét l számított 10 évig üzemeltethet k. A betegszállító szolgáltatók gépjármpark jának cseréje érdekében a szolgáltatók a maradvány erejéig többletfinanszírozásban részesültek.

Mentés: 100,0 millió forint
Kifejezetten és célzottan koraszülött mentésre 100,0 millió forint volt biztosítható az OMSZ részére a maradvány összeg ig.

Legmagasabb progresszivitási szint ellátásokat nyújtó intézményeknek: 750,0 millió forint
A 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján állami fenntartásban m köd országos gyógyintézetek, valamint a 4 orvostudományi egyetem a betegellátásban betöltött, a progresszivitás legmagasabb szintjén való szerepükre tekintettel 50,0 millió forint/intézet kifizetésben részesültek.

Gyermek traumatológiai fix díj: 169,6 millió forint
Az aktív fekv beteg-szakellátás terhére mindösszesen 169,6 millió forint került kifizetésre azon szolgáltatók részére, amelyek gyermek traumatológiai ellátást végeznek, tekintettel arra, hogy a felnőtt traumatológiai ellátást végz szolgáltatók – hasonló ellátási tevékenységük alapján – havi rendszerességgel fixdíjban részesülnek.

Országos gerincsebészeti díj: 120,0 millió forint
A kiterjesztett gerinc-stabilizáló m tétek költségigényességét is figyelembe véve az aktív fekv beteg-szakellátás terhére mindösszesen 120,0 millió forint egyszeri összeg került kifizetésre az ellátást nyújtó szolgáltatók részére.

Rehabilitációs Ellátási Program (REP) támogatása 201,0 millió forint
A REP országos kiterjesztésének érdekében az érintett intézmények a megnövekedett adminisztrációs terheinek fedezetére, a krónikus ágyas beteg-szakellátás terhére összesen 100,0 millió forint kifizetésben részesültek.

A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működési struktúráját és gazdálkodási egyensúlyának javítását célzó intézkedések
Év végén a Kormány döntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egyszeri, a m ködési struktúrát és a gazdálkodási egyensúlyát javító szolgáló kifizetésben részesültek 36 540, 3 millió forint összegben.

Az egyszeri díjazás kifizetésének eljárási szabályait a 359/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, a többletforrást az 1798/2019. (XII. 31.) Korm. határozat a laboratóriumi ellátás, valamint az összevont szakellátás jogcímek n dolgozóinak helyzetének emelésével biztosította, az alábbi táblázatban megjelölt összegekkel.

| Kassza megnevezése | Összeg (millió forint) |
|---|---|
| Laboratóriumi ellátás (PCR) | 3 157,0 |
| Járóbeteg-szakellátás | 15 692,0 |
| Aktív fekvő beteg-szakellátás | 17 709,0 |
| Összesen | 36 558,0 |

A kifizetésben azok a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részesültek, akik 2019. október 1. napján a NEAK-kal szerződéses jogviszonyban álltak és az adott ellátásban a teljesítményük meghaladta a TVK 100,0 százalékát, az alábbiak szerint:

- Az aktív fekvő beteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra szolgáltatásvolumen-szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július havi molekuláris diagnosztikai vizsgálatai többletteljesítményei figyelembevétele alapján egyszeri díjazás illette meg 3157,0 millió forint összegben.
- A járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július közötti időszakban figyelembe vett többletteljesítménye alapján 2019. decemberben egyszeri díjazás illette meg 15 692,0 millió forint összegben.
- Az aktív fekvő beteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkezés a 2018. finanszírozási évben 100,0 százalék felett TVK-t kihasználtságú egészségügyi szolgáltatót, progresszivitási szintenként meghatározott súlyszám-többlet alapú támogatás illette meg. Az egyetemi klinikai központok és a megyei intézmények 2 500 súlyszámnak, az országos intézetek 1 000 súlyszámnak, a városi intézmények és az országos társ-gyógyintézetek 750 súlyszámnak megfelelő, valamint minden más esetben 350 súlyszámnak megfelelő forint összeg egyszeri támogatásban részesültek az aktív fekvő beteg-szakellátásra szerződött szolgáltatók 17 691,3 millió forint összegben.

Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek a NEAK felé történő adatszolgáltatásuk alapján a 2019. december 31-jei állapot szerint lejárt tartozásállománnyal rendelkeznek, a fenti díjazást elsősorban ezen tartozásállomány rendezésére kell fordítsák. A tartozásállomány rendezése a fenntartó egyetértésével a pénzügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere együttes engedélye alapján, az egészségügyi szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósrendezési eljárás szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történhet.

Ellátási formákhoz nem kapcsolható kiadások

Járandóság elleg
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 122/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében december 15-étől kezdődően a szolgáltatók kérelme alapján járandóságelleg folyósítható. Ellegként az Ávr. 123. § (8) bekezdése alapján az érintett egészségügyi szolgáltatási évre vonatkozó 12 havi finanszírozási összegből számított havi átlagának 40,0 százaléka utalható ki.

A 2019. évet terhelő járandóságelleg kiutalására nem került sor.

M ködési költségelleg

A kötelez egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 35. §-ának (4) bekezdése alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 1997. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6/A. §-a szerinti finanszírozási elegben – a költségvetés e célra szolgáló el irányzata terhére – az el z évhez hasonlóan 9 szolgáltató részesült.

A kassza éves keretének felhasználására vonatkozó szabályok szerint: az év közben, a szolgáltatók egyedi kérelme alapján, a NEAK f igazgatójának engedélyével kifizetett leget a tárgyévben vissza kell fizetni. A ködési költségelleg maximálisan adható összege a szolgáltatónak az igénylést megel z 12 havi finanszírozási összegb l számított havi átlagösszeg 30,0 százaléka.

A Kr. 6/F. §-a alapján a ködési költségelleg el irányzata terhére a gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozása szabályainak megváltozása miatt a megváltozott finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára – az ellátás zavartalansága érdekében – el leg folyósítható. E jogcímen, hasonlóan az el z évekhez, nem történt kifizetés.

Az el z évhez viszonyítva a kiutalt elleg összege 158,6 millió forinttal csökkent. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelel en együttesen 905,4 millió forint kifizetésére került sor, melynek visszavonása év végéig megtörtént.

Jogviszony-ellen rzés

Az Ebtv. végrehajtásáról rendelkez 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. § rendelkezései alapján a – a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesít szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igényl diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével – valamennyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megel z en ellen rizni az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot (jogviszonyt). Az ellenrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.

Amennyiben a szolgáltató az ellen rzési kötelezettségét nem teljesítette, akkor a Kr. 4/A. §-a alapján az adott ellátás után járó finanszírozási összegnek csak a 90,0 százalékra jogosult; a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolgáltatók esetén a meghatározott országos átlagos esetdíj 10,0 százaléka, illetve a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10,0 százaléka – legfeljebb 1 000 forint – kerül levonásra a díjazásból.

Ha az ellenrzési kötelezettségét teljesítette a szolgáltató, akkor ellátási esetenként 50 forint ellen rzési díjra jogosult.

A jogviszony ellenrzési díjat a havi finanszírozás keretében kell kifizetni.

A jogviszony ellenrzés „50 forintos” díjazása tekintetében, és a szankcionálás miatti összegének nagyságában jelentsebb változás az el z év azonos id szakához képest nem történt. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 2019-ben a visszavonás összesen 184,8 millió forint, míg a kifizetés 5223,7 millió forint volt.

Összességében a jogviszony elvéréshez kapcsolódó szankcionálások és kifizetések egyenlege 5038,8 millió forint volt, mely 0,8 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

Többletkapacitás befogadások

A Kt. 15. § (2) bekezdése alapján: „Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 3000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.” E forrás szolgál többek között az előzetesen – pl. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), Regionális Operatív Programok (ROP), illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében – befogadott, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 13-15/A. § szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás keretében befogadott többlet-kapacitásokra.

Tekintettel arra, hogy a 2018. évi befogadások 2019. évre áthúzódó költségvetési hatásának fedezetét a beszámolási időszakban rendelkezésre álló, elkülönített fejlesztési keret terhére kellett biztosítani, ezért a beszámolási évben többletforrással járó befogadás nem történt.

Az uniós forrásokból megvalósuló, előzetesen befogadott többletkapacitásokra a beszámoló év során 1 szolgáltatóval járóbeteg-, laboratóriumi és egynapos ellátás vonatozásában, 1 szolgáltatóval járóbeteg-, aktív- és krónikus fekvő beteg-szakellátás vonatozásában került sor szerződéskötésre, 2 szolgáltató pedig járóbeteg-szakellátás többletkapacitást szerzett le.
Az előzetesen befogadott többletkapacitásokra vonatkozó TVK megállapítása a Kr. 27/A. § (4) bekezdése alapján történt. Ezen szabályok alapján a TVK módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik, és amennyiben az igazoló az adott szakmában már rendelkezik kapacitással, úgy az egy kapacitásegységre jutó, adott szakmára jellemző országos átlag és az intézményi átlag közül a magasabbat kell figyelembe venni.

Többletkapacitás-befogadási eljárás (TBB) keretében az Eftv. vhr. alapján egy alkalommal történt többletkapacitás befogadás, melyről a NEAK főigazgatója közleményt jelentetett meg 2019. október 8-án. A közlemény egészségügyi szolgáltatóként tartalmazta a befogadott többletkapacitás megjelölését, mértékét, valamint a finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontját. A határozatlan idejű tartalmú finanszírozási szerződések megkötésére legkorábban 2019. november 1-jétől kerülhetett sor, mely a következő beszámolási időszakot érinti. A befogadás minden szolgáltató esetében előirányzat forrás nélküli befogadás volt.

A beszámolási időszakot megelőző évben kihirdetett TBB befogadásoknak megfelelően az aktív fekvő beteg-szakellátás vonatkozásában 3 szolgáltatóval, felül IVF tevékenységre 1 szolgáltatóval, általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra 1 szolgáltatóval, krónikus ellátás vonatkozásában 7 szolgáltatóval került sor finanszírozási szerződéskötésre. Egynapos sebészeti ellátás esetében nem került sor szerződéskötésre.

Járóbeteg-szakellátást érintően 11 szolgáltatóval, laboratóriumi ellátásokra 3 szolgáltatóval történt finanszírozási szerződéskötés.

Az egyes ellátási formák kiadásai

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

A Kt. 139 547,5 millió forintban határozta meg az alapellátási háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi eredeti előirányzatát, az éves kifizetés 139 537,0 millió forint volt.

A 2019. évi teljesítés 4162,1 millió forinttal, 3,1 százalékkal haladta meg a 2018. évi kifizetést. Ez biztosította a forrást a 2018. márciusi havi kifizetésektől kezdődően a háziorvosi szolgálatok rezsitámogatási díjának megemelésére a 2012. évi szintre hozására, valamint a háziorvosi indikátorrendszer díjazásának emelésére, úgy hogy az eddigi 4800,0 millió forintos éves indikátorrendszer díjazás kerete több mint 50,0 százalékkal emelkedett. Így 2019-ben 7,3 milliárd forint (havonta több mint 600,0 millió forint) áll rendelkezésre az indikátorrendszerben elért eredmények díjazására. A praxisokban folyó szakmai és minőségi munka díjazására 2500,0 millió forinttal több került kifizetésre. Az emelt összegű díjazás először 2019. március hónapban került folyósításra a január és február hónapra vonatkozó korrekciós összegekkel együtt.

Az előirányzat felhasználása jogcímenként és az előző évhez képest a következőképpen alakult:

| Jogcím | 2018. évi kifizetés (MFt) | 2018. évi részarány (%) | 2019. évi kifizetés (MFt) | 2019. évi részarány (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fix összeg díjazás | 21 153,6 | 15,6 | 21 291,6 | 15,2 |
| Rezsitámogatási díj | 39 924,4 | 28,0 | 39 592,1 | 28,4 |
| Területi kieg. díjazás | 2 591,0 | 1,9 | 2 590,9 | 1,9 |
| Eseti ellátás díjazása | 500,1 | 0,4 | 512,6 | 0,4 |
| Teljesítmény díjazása | 63 049,1 | 46,6 | 65 381,0 | 46,8 |
| Ügyeleti szolgálat | 10 156,7 | 7,5 | 10 168,8 | 7,3 |
| Összesen | 135 374,9 | 100 | 139 537,0 | 100 |

A nem bejelentkezett biztosítottak eseti ellátásának díjazására 512,6 millió forint kifizetés történt. Ez szinte megegyezik, az előző évben kifizetett összeggel, mivel az eseti ellátások száma 2019-ben alig változott az előző évhez képest.

Az online jogviszony ellenőrzésekre 2647,6 millió forint kifizetés történt, ami szinte megegyezik az előző évben ugyanezen a jogcímen kifizetett összeggel.

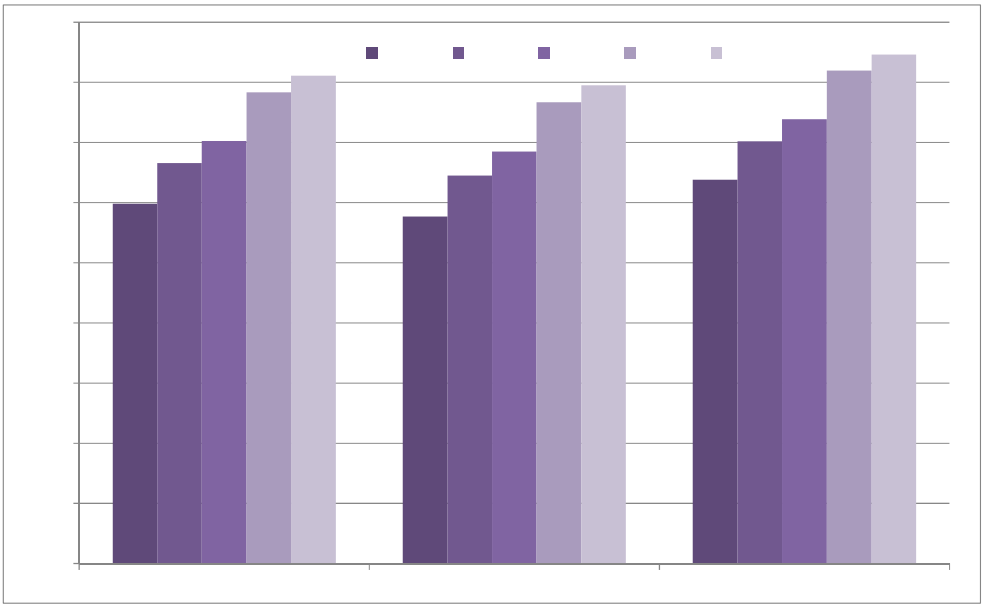
A települési önkormányzatok 2019. évben 11 új körzetet létesítettek, ugyanakkor 8 körzet megszűnt. Területi ellátási kötelezettség nélkül 3 új szolgálat létesült, ezzel szemben 13 ilyen típusú szolgálat megszűnt. Az előző évekhez hasonlóan viszonylag kevés új körzet került kialakításra, ugyanakkor kevesebb esetben fordultak kisebb ellátandó lakosságszámmal bíró, egymás mellett található körzetek összevonásáért. Az új, területi ellátási kötelezettség nélkül induló szolgálat létesítésére 2012. január 1-jétől kezdődően az ÁNTSZ nem adhat ki működési engedélyt. Kivételt képeznek ez alól a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók, rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által benyújtott praxisfejlesztési igények.

Az elmúlt év folyamán átlagosan 6 516 háziorvosi szolgálat, decemberben is éppen ennyi, azaz 6 516 szolgálat finanszírozására volt érvényes szerződése a NEAK-nak. A finanszírozott praxisok 97,4 százaléka területi ellátási kötelezettséggel, 2,6 százaléka területi ellátási kötelezettség nélkül működött. A praxisok 54,0 százaléka a felnőtt korúak, 23,0 százaléka a gyermekek ellátását biztosította, 23,0 százalékban pedig egyes típusú szolgálatként működött.

A vállalkozási formában működtetett háziorvosi szolgálatok száma 2019. decemberében 5 925 volt, amely az összes finanszírozott praxis 90,9 százalékát teszi ki, ami 1 százalék ponttal kevesebb az előző éves értéknél.

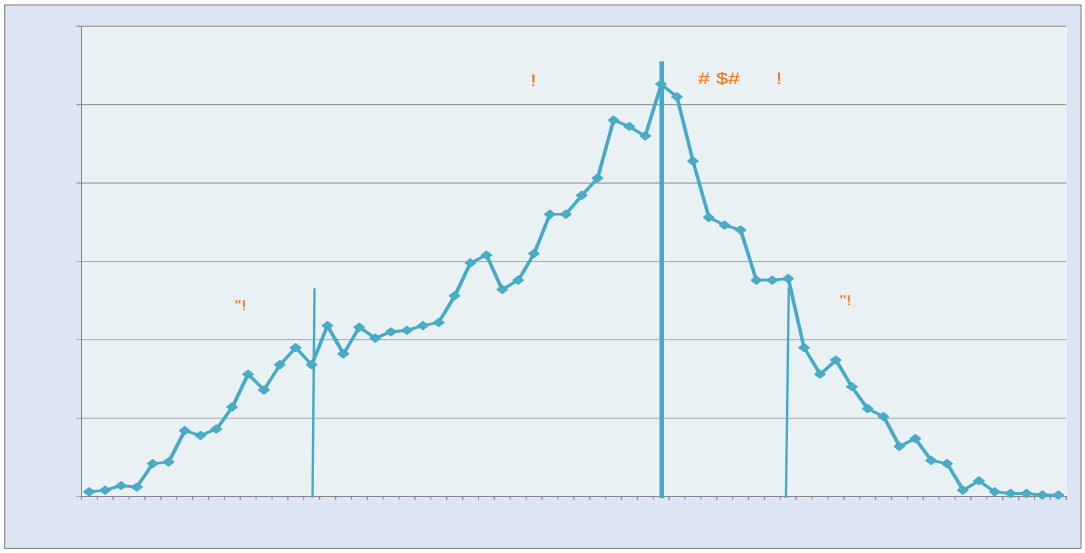
A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok esetében az egy szolgálatra jutó 2019. évi összes finanszírozás átlagos összege (eszközjuttatással és átalánytámogatással) 19,7 millió forint volt, mely közel 1,7 millió forint havi átlagbevételt eredményezett. Ez azt jelenti, hogy a területi ellátási kötelezettség háziorvosi szolgálatok esetében a finanszírozás, a rezsitámogatási díj szintre hozásából és a házi indikátorrendszer díjazásának emeléséből adódóan 3,0 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. A területi ellátási kötelezettséget nem vállaló praxisok átlagos díjazása éves szinten 5,6 millió forint volt, mely havi 491,2 ezer forintot jelentett, azaz esetükben gyakorlatilag nem változott a tavalyi évhez képest a finanszírozás nagysága.

Az egy háziorvosi szolgálatra jutó bevételek alakulását az elmúlt 5 évben az alábbi ábra mutatja be.



A betöltetlen körzetek száma 2019. decemberben volt 464, ebből az egy éven túl betöltetlen praxisok száma 340.

A praktizáló háziorvosok életkorának alakulását 0-tól 92 decemberben – az alábbi ábra szemlélteti.




Azon tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben, melyekben a területi ellátási kötelezettségnek egy évet meghaladóan csak helyettesítéssel tudtak eleget tenni 2006. január 1-jét l, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (a továbbiakban: OTH) közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos igénybevételével is történt a feladatellátás.

Az OTH közrem ködésével 2019-ben 4 háziorvosi szolgálat került betöltésre, 4 szolgálat m ködtetését pedig visszaadta az ellátásért felel s önkormányzatoknak. Így decemberben 21 szolgálatot m ködtetett az OTH. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott körzetek finanszírozása 60,0 százalékra csökkentett fix összeg s területi kiegészít díjazással történt.

Az el z évhez képest nem változott a hajléktalanok háziorvosi ellátását biztosító szolgálatok száma. Decemberben összesen 13 hajléktalanokat ellátó háziorvosi szolgálat, 10 hajléktalan centrum és hozzájuk tartozó mozgó szakorvosi szolgálat m ködött országosan. Fix összeg díjazásukra – éves szinten – összesen 1969,1 millió forint került kifizetésre, ami 6,7 százalékkal haladja meg a 2018-as kifizetést.

A háziorvosi ügyeleti ellátás díjazására 2019. évben 10 168,8 millió forint kifizetés történt, mely gyakorlatilag megegyezik az el z évi finanszírozási összeggel. A központi ügyeleti szolgáltatók száma 2019. december hónapban 231, az általuk ellátott lakosságszám meghaladta 9,960 millió f t. Ez azt jelenti, hogy – a 2018-as évhez viszonyítva tovább növekedve – az ország lakosságának több, mint 99,2 százaléka központi ügyeleti ellátás keretein belül veheti igénybe a sürg sségi ellátás e szintjét.

Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
A 2019-es évben a véd n i szolgálatok, valamint az anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok finanszírozására 26 851,9 millió forint került kifizetésre.

Iskola-egészségügyi ellátás 2019. évi eredeti irányzata 2317,1 millió forint volt, a módosított elirányzata és a tényleges kifizetés összege 2617,1 millió forint, amelyek 12,9 százalékkal haladják meg az el z év adatait. Az iskola-egészségügyi ellátás normatív rendszerben történ finanszírozása keretében 654,0 millió forint kifizetés történt, amely 12,3 százalék növekedést mutat az el z évi adatokhoz viszonyítva. Ennek oka az iskolai orvosi ellátást biztosító szolgálatok év végi egyszeri száma. A Kr. 20. § (3) bekezdése alapján a

díjazás alapjául szolgáló havi fejkvóta összege 8 47 forint. A normatív rendszerben finanszírozott szolgálatok száma 2019. december hónapban 2 906, amiből betöltetlen 240, az ellátandó létszám pedig 1 001 841 fő volt.

Az iskola-egészségügyi ellátás keretén belül állású iskolaorvossal működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok finanszírozására 983,1 millió forint kifizetés történt, ami 13,2 százalékkal magasabb azzel évi adatokhoz képest, az iskolaorvosi ellátást tartós szolgálatok év végi egyszeri díjazása miatt. Tartós helyettesítés miatt 19 szolgálat kapott csökkentett finanszírozást, ami minimálisan kevesebb szolgálatot jelent az előző évi adatokhoz (22) képest.

F állású iskolaorvossal működő szolgálatok száma év végén 240, a betöltetlen állások száma 80. A fállású iskolaorvosi szolgálatok által ellátandók száma: 444 519 fő volt.

December hónapban 4 021 területi védőnői szolgálatot (2 008 területi és 2 013 vegyes körzete), valamint 1 003 iskolavédőnői szolgálatot finanszírozott a NEAK. A területi és az iskolavédőnői szolgálatok száma az előző év december havi adataihoz viszonyítva minimálisan emelkedett. A területi védőnői szolgálatok által ellátott gondozottak és iskolás száma 1 005 968 fő, az iskola védőnői szolgálatok által ellátottak száma 825 970 fő volt. Egy körzeti védőnői szolgálatra átlagosan 250 fő gondozott, egy iskolavédőnői szolgálatra pedig 823 fő gondozott jutott. December hónapban 375 betöltetlen szolgálatra (324 területi + 51 iskolavédőnői) volt finanszírozási szerződés, tartós helyettesítés miatt 251 területi védőnői szolgálat és 12 iskolavédőnői szolgálat részesült csökkentett finanszírozásban.

A védőnői ellátás fix összeg és az ellátandók létszáma alapján járó díjazásán kívül, továbbá a népegészségügyi célú méhnyakszűrés jelentett eseteire összesen 23 538,3 millió forint kifizetés történt. A területi védőnői szolgálatok több település ellátásáért kiegészítő díjazásban részesülnek, melynek 2019. évi összege 203,7 millió forint volt. A területi védőnői szolgálatoknak 2015. október 1-jétől lehetőségük van népegészségügyi célú méhnyakszűrésre finanszírozási szerződést kötniük, melynek finanszírozása teljesítményalapú, a jelentett és finanszírozható esetek határozzák meg. Az egy esetre jutó finanszírozási díj mértéke 2000 forint, a feladatellátásra biztosított 2019. évi keret 480,0 millió forint volt. Decemberben 397 szolgálat rendelkezett szerződés-kiegészítéssel erre a tevékenységre, az éves esetszám 577, ami alapján az éves kifizetés összege 1,2 millió forint.

Az anya-, gyermek- és csecsemővédelem elirányzat terhére az anyatejgyűjtő állomások és a speciális gyermek-egészségügyi ellátás finanszírozása történik. E feladatok finanszírozására éves szinten 478,6 millió forint kifizetés történt, melyből az anyatejgyűjtő állomások finanszírozása 307,9 millió forint volt, míg a speciális gyermek-egészségügyi feladatokra 170,7 millió forint jutott. A kassza kiadása minimálisan változott az előző évhez képest, a speciális gyermek-egészségügyi ellátásban részesülő gondozottak létszám csökkent.

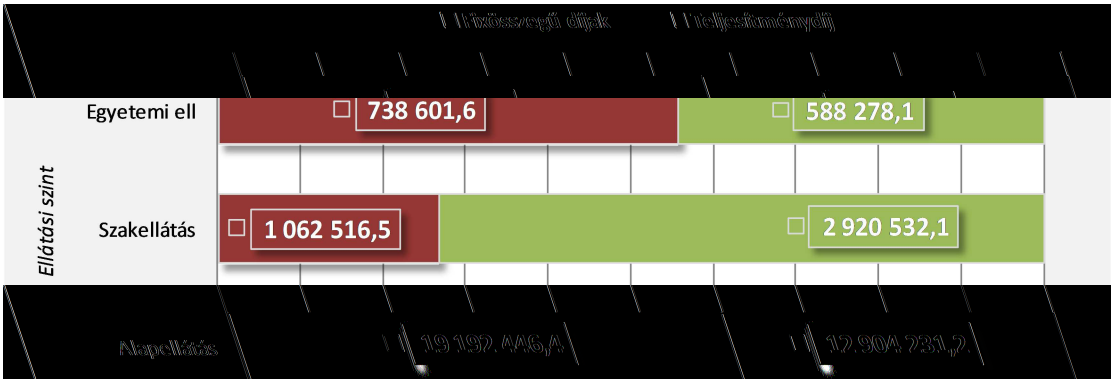
A 2019-es évben 57 gyermekgyógyászati és 47 gyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat (a továbbiakban: MSZSZ) működött. A szolgáltatók finanszírozásának alapja az elfogadott esetszám. A gyermekgyógyászati MSZSZ-ek éves jelentett esetszáma 41 450, az éves korrekciós esetszám pedig 542 volt, míg a gyógyászati MSZSZ szolgáltatók korrekcióval módosított éves esetszáma: 13 813.

A MSZSZ-ok működtetésére összesen 217,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a gyermekgyógyászati szolgálatok 121,6 millió forintot, szolgálatonként havonta átlag 177,8 ezer forintban, míg a gyógyászati szolgálatok 96,3 millió forintban, átlagban havi 170,7 ezer forintban részesültek. Gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatoknál az egy esetre jutó kifizetés átlag 2,9 ezer forint, míg gyógyászati ellátás esetén 7,0 ezer forint volt.

Fogászati ellátás

A fogorvosi ellátásra a Kt. 32 894,8 millió forint eredeti előirányzatot határozott meg. Az alapellátás részére az év végi egyszeri kiegészítő díj kifizetése nagyrészt a természetbeni ellátások céltartaléka terhére átcsoportosított 0,44 millió forint biztosításával valósult meg. A módosított előirányzat 37 354,3 millió forint, ami szinte teljes összegben kifizetésre (37 354,2 millió forint) került.

Az éves teljesítés az előző évi kiadáshoz viszonyítva 16,5 százalékkal magasabb. A teljesített kifizetés megoszlása: alapellátás 85,8 százalék, szakellátás 10,6 százalék, egyetemi szakellátás pedig 3,6 százalék. Az elmúlt évi kisebb részaránya az alapellátásnál és az egyetemi ellátásnál 0,1 százalékkal csökkent, a szakellátásnál 0,2 százalékkal, emelkedett. A kifizetés 56,1 százaléka fix összeg, 43,9 százaléka teljesítményarányos díjazásra szolgál. A fixösszeg kifizetések részarányának emelkedését a rezsitérítési díj bevezetése eredményezte.




Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2 321 (összesen heti 76 327 óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelyek heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 441 szakrendelés heti 10 447 óra kapacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti rendelési ideje 2 600 óra volt.

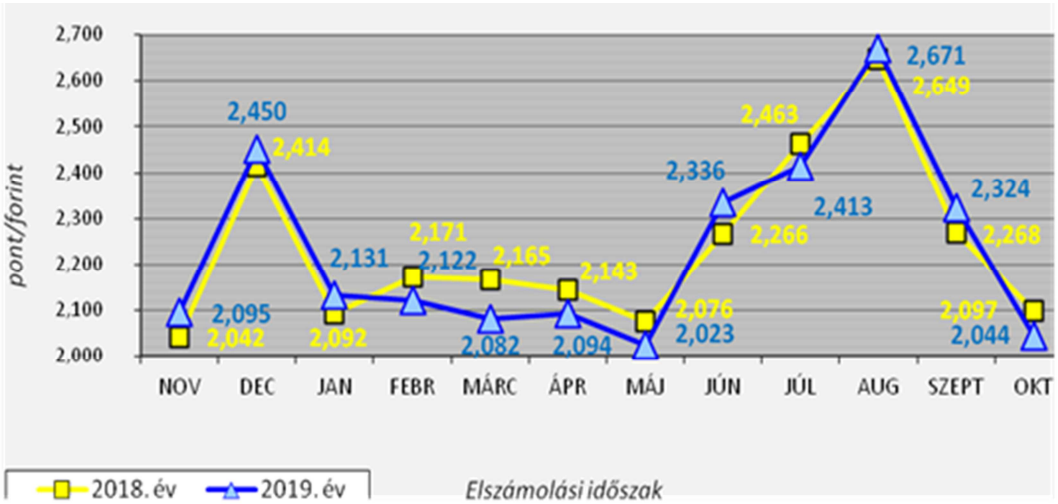
Az előző évhez viszonyítva a kapacitásadatokban kismértékű változás történt, a fogászati szolgálatok/szakrendelések száma és a heti rendelési idő 0,3 százalékkal emelkedett.

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős eltérést nem mutat, a szervezeti egység típusai tekintetében azonban eltérő mértékű változás mutatható ki az előző évi adatokhoz képest. Az ügyeleti szolgálatoknál történt nagyobb mértékű emelkedés, a szolgálatok száma 5,6 százalékkal, a heti rendelési idő 8,1 százalékkal lett magasabb. Az iskola-ifjúsági szolgálatok száma és heti rendelési ideje közel azonos mértékben emelkedett. Kis mértékben változott a felnőtt szolgálatok kapacitása, 0,4 százalékkal nőtt a szolgálatok száma, a heti rendelési idő 0,2 százalékkal magasabb. Csökkent a kapacitás a gyermek szolgálatok esetében, a szolgálatok száma 0,2 százalékkal, a rendelési idő 0,8 százalékkal alacsonyabb. A gyermek szolgálato

száma nem változott, a heti rendelési id 0,1 százalékkal csökkent. Az egyetemi alapellátás kapacitásadataiban nem volt változás.

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az évhez képest kis mértékben emelkedett, a szakrendelések száma nem változott, a heti rendelési id 0,6 százalékkal magasabb.
A kapacitásadatok a szakrendelések típusait tekintve eltér mérték változást mutatnak. Jelents kapacitás-változás a gyermekek szakellátásában történt szakrendelések esetében volt, a szakrendelések száma 4-6 szakrendelésre, azaz 50,0 százalékkal emelkedett, a heti rendelési id 40 óráról 77 órára, azaz 92,5 százalékkal n tt.
Kisebb mérték a kapacitás emelkedése a szájsebészeti szakrendelések esetében, a szakrendelések száma 0,9 százalékkal, a heti rendelési id 1,8 százalékkal magasabb. Eltér mértékben változott a kapacitás a fogszabályozási szakrendelések esetében, a szakrendelések száma 0,6 százalékkal csökkent, a heti rendelési id 0,4 százalékkal alacsonyabb. A fogászati röntgen szakrendelések száma 2,2 százalékkal bővült, a rendelési id 0,3 százalékos csökkenést mutat.

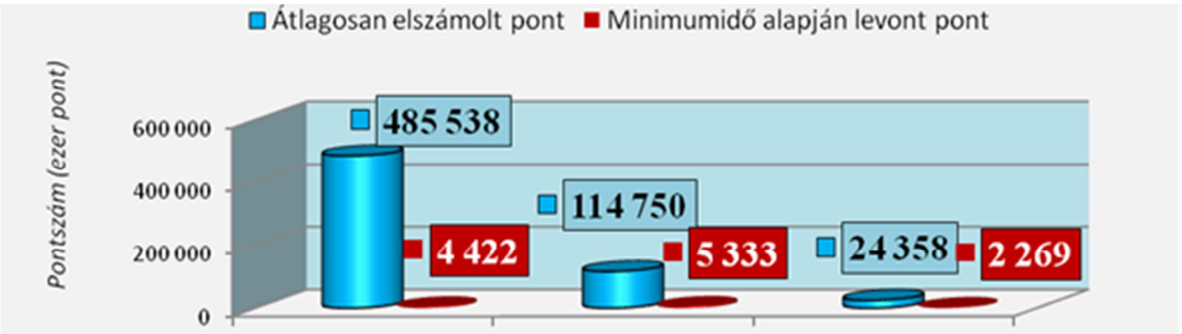
Nagyobb mérték csökkenés a parodontológiai szakrendelések esetében volt. A szakrendelések száma 11,1 százalékkal, a rendelési id 4,3 százalékkal csökkent. A fogyatékkal él gyermekek és felnttek szakellátását biztosító szakrendelések és az egyetemi szakellátás esetében változás nem történt.

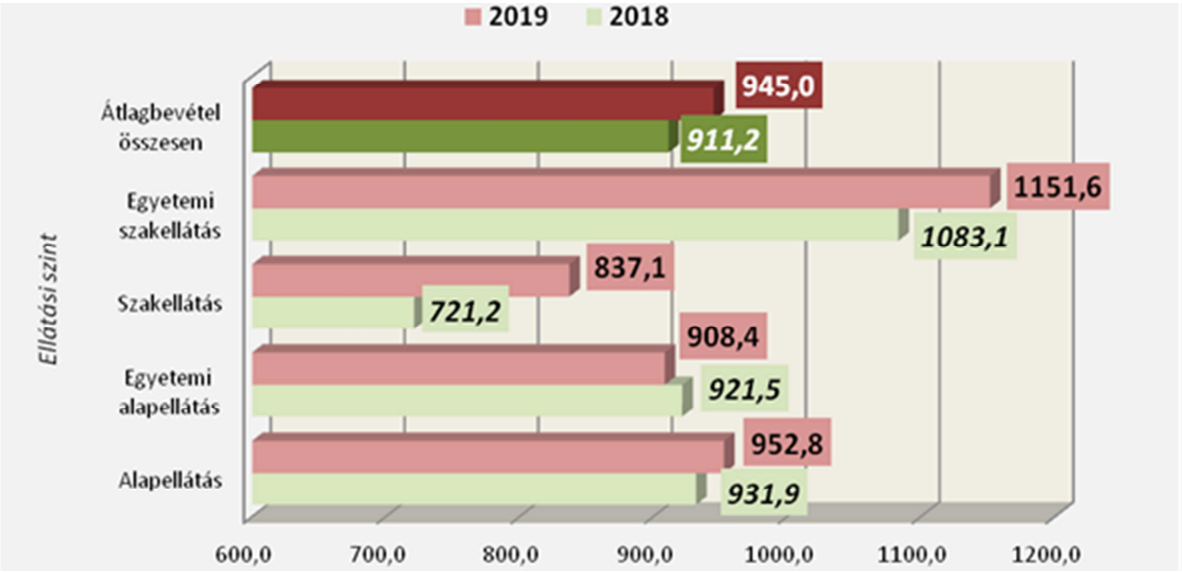



A pontérték alakulása – figyelembe véve a szezonális ingadozást – kiegyensúlyozott képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összesen 1,5 százalékkal n tt. Az el z évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 0,9 százalékkal magasabb. Nagyobb mérték emelkedés történt a szakellátás területén, a teljesítménypontok száma a szakellátásban 4,8 százalékkal magasabb. Az egyetemi szakellátásban kis mértékben, 0,4 százalékkal csökkent a teljesítménypontok száma.

A Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi alap/szakrendelés tárgyhavi teljesítményéb l a havi maximális teljesítményértéket meghaladó értékek nem számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,2 százaléka került levonásra.

Ellátási szintenként a jelentett pontszámból az alapellátásban 0,9 százalékos, a szakellátásban 4,6 százalékos, az egyetemi szakellátás esetében 1,3 százalékos mértéklevonás történt. Az előző évhez viszonyítva 1,5 százalékkal nőtt a levonásra került pontszámok száma.



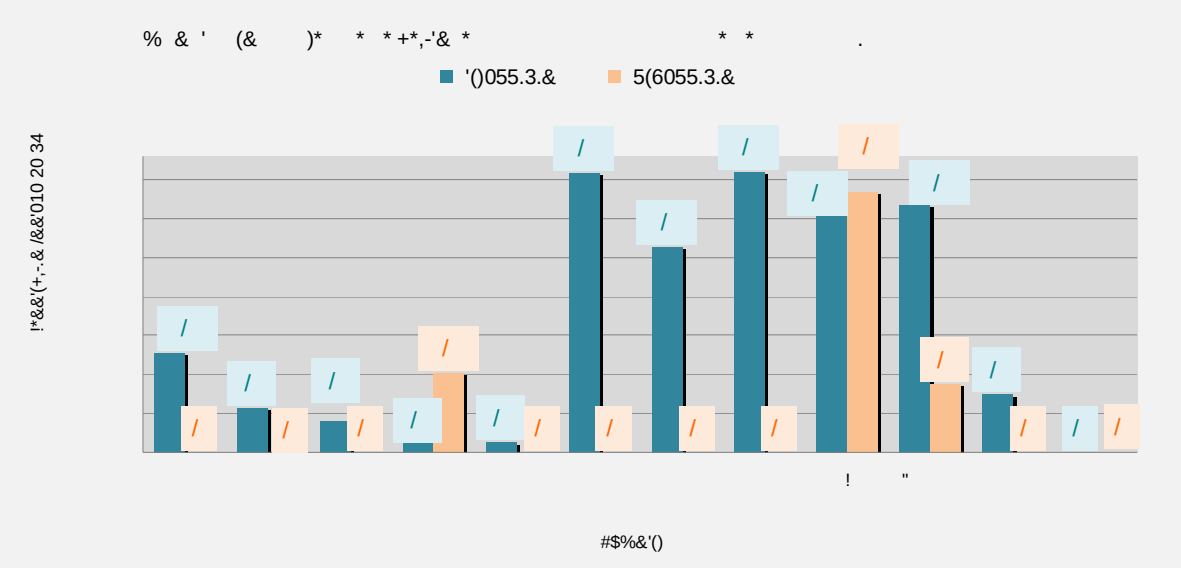

Az alapellátásban az átlagbevétel 2,2 százalékkal nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. A szakellátásban nagyobb mértékű, 16,1 százalékos átlagbevétel-emelkedés történt. A egyetemi szakellátás 6,3 százalékos emelkedést mutat.

Az alapellátás keretében nagyobb mértékű emelkedés a gyermek szolgálatokat érintette, az átlagbevétel 4,6 százalékkal magasabb. Az iskola-egészségügyi szolgálatok átlagbevétele 2,6 százalékkal nőtt. Közel azonos mértékben emelkedett a felnőtt és a vegyes szolgálatok átlagbevétele az előző időszakhoz viszonyítva. Nagyobb mértékben, 6,8 százalékkal csökkent az átlagbevétel az ügyeleti szolgálatok esetében. Az egyetemi alapellátás átlagbevétele 1,4 százalékkal alacsonyabb.

A szakellátás keretében a legnagyobb mértékű, 20,2 százalékos bevétel-emelkedés a fogszabályozási szakellátás esetében történt. Nagyságrendben ntt a szájsebészet átlagbevétele, 15,7 százalékkal magasabb az el id szakhoz képest. Közel azonos mértékben emelkedett a parodontológiai és fogászati egyetemi szakellátást nyújtó szakrendelések átlagbevétele 6,3 százalékkal magasabb. A fogyatékkal él gyermekek szakellátását biztosító szakrendelések átlagbevétel 7,1 százalékkal emelkedett, a fogyatékkal élfeln ttek szakellátását biztosító szakrendelések esetében minimális mértékben ntt. Kizárólag a gyermek szakellátást nyújtó szakrendelések átlagbevételében mutatható ki csökkenés, mely 15,7 százalékkal alacsonyabb az el z id szakhoz képest.

A Kr. 22. § (8) bekezdésében foglaltak szerint rületi ellátási kötelezettség nélkül kötött fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató (ideértve az egyetemi alap-és szakellátást nyújtó szolgáltatót is) abban az esetben jogosult alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szolgálat/szakrendelés ellátást nyújtott. Ha adott fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhónapra vonatkozóan teljesítményt-jelentést nem adott le, akkor a kifizetett alapdíj visszavonásra került.

Éves szinten a visszavonás 35 szolgáltató 37 szervezeti egységét érintette, összesen 2 460,2 ezer forint alapdíj visszavonására került sor. A visszavonás megoszlása: alapellátás 21,3 százalék, szakellátás 78,7 százalék.




Egyszeri kiegészít díj kifizetése

A közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészít díjazásban részesültek 2019. decemberben, mindösszesen 44 459,4 forint összegben. A heti 30 órában mködtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelések esetében egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre, alacsonyabb rendelési idesetén id arányosan csökkentett díj került megállapításra. Az egyszeri kiegészít támogatásban 2 291 alapellátási és szakellátási szolgáltató 3 388 szervezeti egysége részesült.

## Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás

A Kt. 2019. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvény halottszállítás finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6796,9 millió forintot irányzott elő, ami – a gyógyító-megelőző ellátás céltartaléka jogcím terhére 2500,0 millió forint összegben jóváhagyott kormány hatáskör, illetve további miniszteri hatáskörben végrehajtott 376,2 millió forint összeg átcsoportosítás figyelembevételével – 9673,1 millió forintra módosult. A kifizetés ezzel azonos összegben valósult meg, amely az előző évi kifizetésnél 1126,2 millió forinttal (13,2 százalékkal) volt magasabb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg 9595,8 millió forint volt, mely 1132,9 millió forinttal (13,4 százalékkal) több, mint az előző évi. Az egy km-re jutó átlagos havidíj 275,0 forint volt, mely összeg 106,4 forinttal (63 százalékkal) volt magasabb a 2018. évi átlag értékhez képest.
Ez az emelkedés részben az említett kormány hatáskörű irányzat átcsoportosításnak, részben a betegszállítás finanszírozásában bevezetett finanszírozási elszámolásnak volt köszönhető. A Kr. 2019. január 1. napjától hatályos 33. § a) pontjának bekezdéseinek értelmében a teljesítménydíj számításának alapja a betegszállítási utalványon jelölt felvételi és átadási települések középpont koordinátái által határozott legrövidebb közúti közlekedési távolság. Az új elszámolás az eddigiekkel ellentétben nem a szolgáltatók által ténylegesen megtett és kilométeróra állás alapján jelentett távolságok szerint történik, hanem – több más részletszabályozás mellett – egy un. település távolság mátrix alapján meghatározott kilométerértékkel, mely így minden szolgáltató, de minden egyes szállítására nézve egy, a szolgáltató által választott haladási útvonaltól független érték. A bevezetett új elszámolási módszerrel egy igazságosabb, egzakt elosztási rend jött létre.
A NEAK 2019. évben 59 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszírozta az Ellátási és Koordinációs Fosztályok által kötött szerződések alapján. Decemberben az 53 szerződött szolgáltató összesen 469 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 3 db-bal (4,9 százalékkal), az aktív gépjárműveik száma 4 darabbal (1,31 százalékkal) csökkent, a tartalék gépjárműveik száma 60 darabbal (33,3 százalékkal) nőtt.

Az orvosi rendelvény halottszállítás költségtérítésére 77,3 millió forint került kiutalásra, ami 6,7 millió forinttal (8,0 százalékkal) kevesebb, mint a 2018. évi kifizetés.
A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 664 esettel (8,39 százalékkal) volt kevesebb, így összesen 7 235 esetet – ebből közigazgatási határon

belüli szállításként 3 331 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 3 919 esetet – finanszírozott a NEAK.
Az egy halottszállítási esetért járó költségtérítés összege a 2018-as évhez képest nem változott. A közigazgatási határon belüli szállítás esetén 8 400 forint, a közigazgatási határon kívüli szállítás esetén 12 600 forint illeti meg a szolgáltatókat. A 2019-es évben a 64 kórboncolási célból végzett halottszállításra finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató közül 51 szolgáltató jelentett halottszállítási tevékenységet. Decemberben 64 szolgáltató rendelkezett halottszállításra finanszírozási szerződéssel, ez 1,59 százalékkal több, mint 2018-ban. A rendelkezésre álló, havonta meghatározott keretösszegből a halottszállítás költségtérítése után a fennmaradó összeg kerül felosztásra a betegszállító szolgáltatók között, a teljesítményük arányában.

Művesekezelés
Az E. Alap 2019. évi költségvetésében a dialízises ellátások finanszírozására 23 171,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, amely a gyógyító-megelőző ellátás céltartaléka jogcím terhére átcsoportosított 2300 millió forinttal módosult. A módosított előirányzattal azonos összeg, 25 471,1 millió forint került kifizetésre. Az ellátás finanszírozásában jelentős változások az előző évhez képest nem történtek.

A 2019. év végi állapot szerint 17 szolgáltatónál 410 kezelőhellyel 68 állomásra volt érvényes finanszírozási szerződése. A dialízis szolgáltatók részére összesen 2 307 dialízis kezelés került elszámolásra.

Elszámolt kezelésszámok, kezelési típusonként

| Kezelés típusok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kezelés szám | Kezelés szám | Kezelés szám | Kezelés szám | Kezelés szám változás |
| Akut haemodialízis | 5 436 | 5 012 | 5 380 | 4 551 | 84,59% |
| Krónikus haemodialízis | 154 705 | 158 167 | 149 954 | 147 516 | 98,37% |
| Haemofiltráció | 3 982 | 4 131 | 4 066 | 3 853 | 94,76% |
| High flux kezelés | 305 887 | 315 275 | 329 255 | 335 686 | 101,95% |
| Haemodiafiltráció (on-line) | 403 019 | 392 174 | 384 041 | 386 619 | 100,67% |
| Haemoperfuzio | 25 | 20 | 34 | 25 | 73,53% |
| Összesen: | 873 054 | 874 779 | 872 730 | 878 250 | 100,63% |
| CAPD kezelés* | 315 257 | 311 357 | 324 370 | 323 973 | 99,88% |

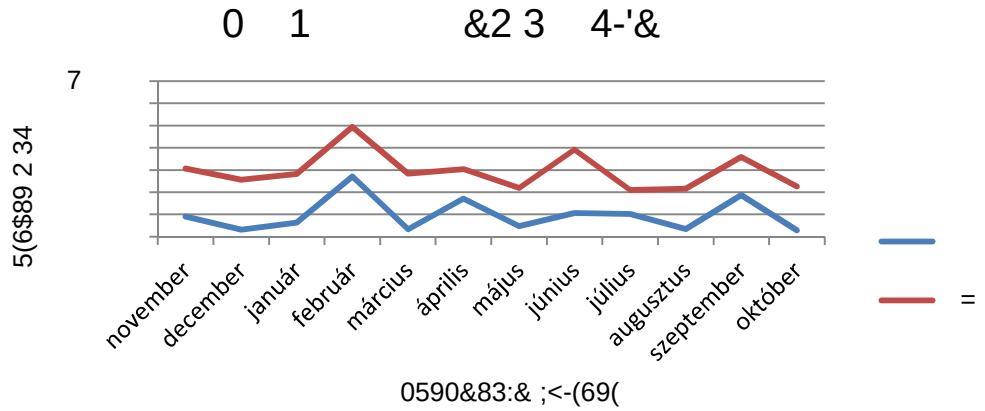
*A CAPD kezelések esetében az értékek a kezelési napok számát jelölik

Októberben (december havi kifizetés) 6 055 krónikusan dializált beteg volt, a CAPD-vel (folyamatos ambuláns peritoneális dialízis) kezeltek száma 928 fő, az EPO (eritropoietin) kezelésben részesülő predializált betegek száma pedig 4 771 volt.

Az előző év azonos időszakához képest minimális betegszám-növekedés tapasztalható a krónikus dializált betegek számában (0,6 százalék), mint az EPO kezelésben részesülő betegek számában (4,6 százalék), ezzel szemben a PD-vel kezelt esetek számában (1,8 százalék) csökkenés figyelhető meg. Az egy művesekezelésre jutó alapdíj összege átlagosan 22 958,4 forint volt, mely 1 218,5 forinttal, azaz 5,3 százalékkal több az előző finanszírozási

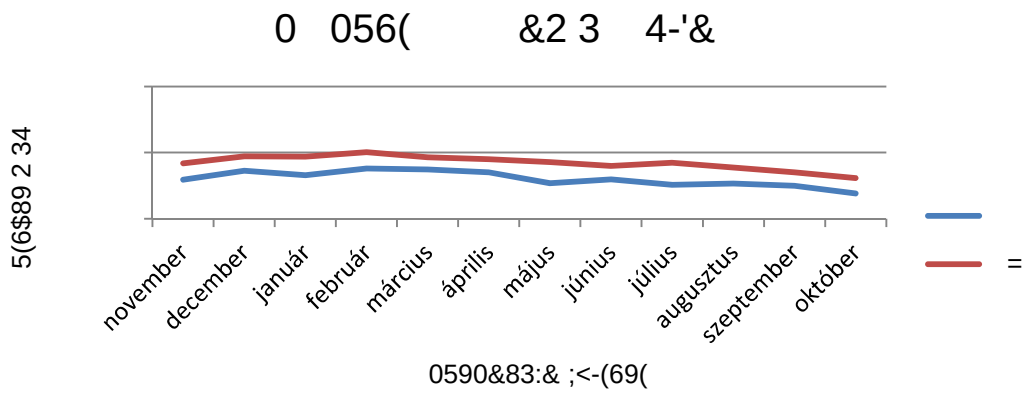
év átlagához viszonyítva, köszönhetően az elirányzat növekedésének, ugyanezen szakban a kezelésszám átlagosan 0,6 százalékkal növekedett.

Az alapdíjak alakulását a 2018-2019. finanszírozási évi vonatkozásában, havi bontásban az alábbi grafikon szemlélteti.




A predializált betegek EPO kezelése vonatkozásában az alapdíj összege átlagosan 24 231,9 forint volt, mely 1 989,0 forinttal, azaz 9,5 százalékkal magasabb az előző finanszírozási évi átlaghoz viszonyítva.

Az EPO alapdíjak alakulását a 2018-2019. év vonatkozásában, havi bontásban az alábbi grafikon szemlélteti.




Otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás

Az ellátás finanszírozására 2019. évben eredetileg előirányzatként 5596,8 millió forint állt rendelkezésre, amely az év végi miniszteri hatáskörű csoportosítást követően 6558,3 millió forintra módosult, az éves kifizetés 6558,2 millió forint volt.

Otthoni szakápolás

Az otthoni szakápolás éves kifizetése: 5426,4 millió forint volt. A teljesítmény-díjazásra 4391,1 millió forint, területi pótlékra 204,6 millió forint együttesen 4595,7 millió forint került kifizetésre, ebből a rehabilitációs tevékenységek díjazása 1886,6 millió forint, az ellenőrzések miatti visszavonás kamattal növelt összege 6,7 millió forint volt.

A szolgáltatóktól zárolt, illetve visszaérkezett összeg 2,8 millió forint volt, míg év végi kasszamaradványként 828,0 millió forint került zárolásra.

Az otthoni szakápolásban 76 421 eset keretében 2 538 beteg ellátására került sor. A betegek átlag 24,18 vizitet kaptak az ellátásban, átlag 675 forint ápolási költséggel. Az otthoni szakápolás 2019. évi kapacitás kihasználtsága 102,6 százalék.

A TIOP, ROP pályázati formában korábban befogadott szolgáltatók részére, az otthoni szakápolás keretében elkülönített kapacitások kihasználtsága 23,2 százalék volt. Az ellátási forma finanszírozási egysége a vizit, alapdíja 2019-ben 3 700 forint maradt.

Otthoni hospice ellátás
A hospice ellátás éves kifizetése: 1131,8 millió forint volt. A teljesítménydíjazásra 910,0 millió forint, míg területi pótlék címen 49,8 millió forint, együttesen 959,8 millió forint került kifizetésre, ebből az ellenőrzések miatti visszavonás kamattal növelt összege 6 662 ezer forint. Az év végi kasszamaradványként 172,0 millió forint került kifizetésre.

Otthoni hospice ellátásban 7 017 eset, 6 373 beteg ellátására került sor. A betegek átlag 31,42 napot töltöttek az ellátásban, átlag 150 603 forint költséggel. Az otthoni hospice ellátás kapacitás kihasználtsága 85,7 százalékos volt.

Az ellátási forma finanszírozási egysége az ellátás, alapdíja 2019-ben 4 440 forint, amely 2018-hez képest nem változott.

Célel irányzatok

Méltányossági alapon történő kifizetések terhére finanszírozott eszközök és eljárások
Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között – támogathatóságból a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még nem befogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosító terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak egy részét átvállalhatja.

A Kt. 16. §-a alapján a Természetbeni ellátások keretén belül az adott célirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra eredeti célirányzatként 2611,3 millió forint volt felhasználható, amelyből az eszköz, eljárás finanszírozására irányzott összeg 1283,4 millió forint volt.

November hónapban, a célirányzatok jogcímen belül történő forrásátrendezés keretében, a fiatal szakorvosok támogatása célirányzati sorról 300,0 millió forint került átcsoportosításra a méltányossági alapon történő térítések célirányzatisorra.

A méltányossági alapon történő térítések célirányzatból az eszközök és eljárások fedezeteként 2019. évben összesen 1577,4 millió forint kifizetés történt.

Az egészségügyi szolgáltatások terén folyamatosan jelennek meg az innovatív technológiák. Egy új eljárás egyedi méltányossági alapú finanszírozási kérelmének mérlegelése során az egészségbiztosító figyelembe veszi, hogy van-e olyan finanszírozottan hozzáférhető és tudományos bizonyítékok alapján választható eljárás, amely várhatóan azonos eredménnyel jár. Orvosszakmai indokoltság esetén a rendelkezésre álló keret figyelembevételével kerül sor az elbírálásra.
Amennyiben egy új és egyszer már egyedileg engedélyezett eljárásra vonatkozóan több kérelem benyújtására is sor kerül, akkor az egészségbiztosító – esetszámtól és eljárástól

függ en – egységes elbírálási feltételrendszert dolgoz i. Ebben az esetben az egészségbiztosító független szakmai tanácsadó testület bevonását kezdeményezheti a mérlegelés feltételrendszerének kialakítása, illetve felülvizsgálata érdekében. Ezzel egyidej leg az egészségbiztosító annak a lehet ségét is megvizsgálja, hogy az adott eljárás közfinanszírozásba való befogadásához milyen szakmai, jogszabályi, finanszírozási, költségvetési és egyéb feltételek szükségesek. Amikor az új eljárás alkalmazását illet en kialakul a szakmai konszenzus, és a peremfeltételek adottak, akkor az egyedi méltányosság keretében addig szerzett tapasztalatokra építve eljárás társadalombiztosításba való befogadása kezdeményezhet

Egyedi méltányosság alapján finanszírozott új eljárások

Bizonyos kardiológiai megbetegedések esetén alkalmazható MICRA pacemaker, elektróda eltávolítására alkalmas eszközök, plakk eltávolítására alkalmas eszközök iránti méltányossági kérelmekre adott ki engedélyeket a NEAK 2019. évben. Új eljárásként jelent meg az eddig külföldön, de most már Magyarországon is elérhet genetikai vizsgálatok, a szem ideghártya rosszindulatú daganatának intra-arterialis kemoterápiás kezelése, továbbá a vákumos sebkezelési eljárás méltányosságból történ finanszírozása.

Egyedi méltányosság alapján finanszírozott eljárások

A PET/CT vizsgálat közfinanszírozottan igénybe vehet NEAK rendelet 8. számú mellékletében felsorolt indikációkban. A jogszabályban foglaltakon túl egyedi méltányossági indikációk kérelem alapján vehet igénybe az ellátás.

A PET/MR vizsgálat társadalombiztosításba nem befogadott eljárás. Az alábbi táblázatban feltüntetésre került az engedélyezett PET/CT és /MR vizsgálatok száma, az engedélyezett, illetve a kifizetett összeg.

| 2019. évben egyedi méltányosságból engedélyezett PET/CT és PET/MR vizsgálat | | | |
|---|---|---|---|
| Eljárás megnevezése | Engedélyezett összeg (MFt) | Kiadott engedélyek (db) | Kifizetett összeg (MFt) |
| PET/MR | 7,5 | 39 | 4,6 |
| PET/CT* | 131,9 | 687 | 114,8 |

* Ebtv. 26.§ (1) bek. a) pontja alapján a méltányosságból engedélyezett PET/CT vizsgálatok finanszírozása a speciális finanszírozású szakellátások állományának terhére történt.

Egyes molekuláris genetikai diagnosztikus vizsgálatok, mint az Oncompass, az Oncotype molekuláris diagnosztikai profil vizsgálat, valamint a FoundationOne tumorprofil vizsgálat esetében a NEAK és a diagnosztikai vizsgálatot végz szolgáltató 2019. évben megállapodást kötött az adott évben egyedi méltányossági alapon történ engedélyek esetszámára, a vizsgálatok árára és a keretösszeg finanszírozására vonatkozóan. A megállapodás alapján volt lehet ség arra, hogy a vizsgálatok költségvonzata 2019. évben tervezhet formában alakuljon.

Az alábbi táblázat tartalmazza az engedélyezett onkológiai diagnosztikai vizsgálatok és kezelések számát, összegét és kifizetett összegeit.

| 2019. évben egyedi méltányosságból engedélyezett/kifizetett onkológiai eljárások | | | |
|---|---|---|---|
| Eszköz/eljárás megnevezése | Engedélyezett összeg (MFt) | Kiadott engedélyek (db) | Kifizetett összeg (MFt) |
| FoundationOne tumorprofil vizsgálat* | 110,7 | 71 | 67,0 |
| Oncotype DX molekuláris profil vizsgálat** | 291,6 | 365 | 254,9 |
| Oncompass molekuláris profil vizsgálat*** | 400,6 | 257 | 255,9 |
| Caris Molecular Intelligence | 22,5 | 15 | 10,5 |
| Hasüregi hypertermiás kemoterápia (HIPEC) | 115,5 | 77 | 70,5 |
| Elektrokemoterápiás kezelés | 37,3 | 59 | 28,7 |
| Szelektív intra-arteriális kemoterápia | 6,7 | 5 | 0,7 |
| Mikrogömb | 22,9 | 4 | 17,1 |

* A Foundation One vizsgálat kapcsán beérkezett kérelmek száma 2019. év végén a szerződésben szereplő keretet meghaladta, ennek megfelelően 10 darab kereten túli engedély került kiadásra.

**Az Oncotype DX molekuláris profil vizsgálatra beérkezett kérelmek száma 2019 I. és II. félévében meghaladta a szerződésben szereplő keretet, ennek megfelelően 2019. évre vonatkozóan összesen 171 kereten túli engedély került kiadásra.

*** Az Oncompass molekuláris profil vizsgálatra beérkezett kérelmek száma 2019 I. és II. félévében meghaladta a szerződésben szereplő keretet, ennek megfelelően 2019. évre vonatkozóan összesen 29 kereten túli engedély került kiadásra.

Az egyedi méltányossági alapon engedélyezett kardiológiai és érsebészeti eljárások és eszközök, valamint a férfi inkontinencia kezelésére szolgáló műsphincter és inkontinencia szalag beültetés, továbbá neurostimulátor eszköz vérnyílás-tághosszabbításra szolgáló implantátum, fejmodelláló sapka esetében nagy költségvonzat mutatható ki az alábbi táblázatok szerint.

| 2019. évben egyedi méltányosságból engedélyezett/kifizetett kardiológiai, érsebészeti eljárások és eszközök | | | |
|---|---|---|---|
| Eszköz/eljárás megnevezése | Engedélyezett összeg (MFt) | Kiadott engedélyek (db) | Kifizetett összeg (MFt) |
| Bal pitvari fülcsezárás | 25,4 | 16 | 11,5 |
| CVRx Barostim Neo készülék | 17,8 | 2 | 17,8 |
| Elektróda eltávolító eszköz | 31,8 | 18 | 12,0 |
| GORE-TEX stentgraft | 5,1 | 2 | 0 |
| JETSTREM Atherectomy Sysmem-értágítás | 0,8 | 1 | 0 |
| MICRA incracardialis pacemaker | 32,1 | 11 | 20,4 |
| Percutan MitraClip beültetés | 413,8 | 46 | 332,8 |
| Percutan zárás | 5,2 | 1 | 0 |
| Plug | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Subcutan ICD | 177,1 | 20 | 123,8 |
| Symplicity Spyral katéter | 7,4 | 3 | 7,4 |
| TAVI | 62,2 | 8 | 57,1 |
| Transzkatéteres pulmonális billenty | 33,3 | 7 | 18,5 |
| ViaCare küls ellenpulzációs pumpa | 15,2 | 19 | 10,4 |

| 2019. évben egyedi méltányosságból engedélyezett, finanszírozott inkontinencia kezelésére szolgáló eszközök | | | |
|---|---|---|---|
| Eljárás megnevezése | Engedélyezett összeg (MFt) | Kiadott engedélyek (db) | Kifizetett összeg (MFt) |
| Inkontinencia szalag | 10,8 | 7 | 7,7 |
| M sphincter | 95,0 | 43 | 70,4 |

| 2019. évben egyedi méltányosságból engedélyezett, egyéb költségvonzatú eszközök | | | |
|---|---|---|---|
| Eljárás megnevezése | Engedélyezett összeg (MFt) | Kiadott engedélyek (db) | Kifizetett összeg (MFt) |
| Neurostimulátor | 19,6 | 1 | 19,6 |
| Fejmodelláló sapka | 16,7 | 15 | 14,5 |
| Vákumos sebkezelési eljárás | 30,8 | 96 | 5,4 |
| Végtaghosszabbító eszköz | 30,5 | 4 | 22,9 |

A fogászati ellátás során részleges térítés mellett igénybe vehet szolgáltatások fogorvosi munkadíjának átvállalása, valamint társadalombiztosítási támogatással rendelhető eszközök listáján nem szerepl fogtechnikai eszközökre (fogpótlások, fogszabályozó eszköz) vonatkozóan kiadott engedélyek és kifizetett összegek adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| 2019. évben egyedi méltányosságból engedélyezett, finanszírozott fogászati ellátások | | | |
|---|---|---|---|
| Eszköz/eljárás megnevezése | Engedélyezett összeg (MFt) | Kiadott engedélyek (db) | Kifizetett összeg (MFt) |
| Fogorvosi ellátás fogorvosi díja | 127,1 | 288 | 95,0 |
| Fogorvosi ellátás fogtechnikai díja | 107,1 | 318 | 84,2 |

A táblázatokban szereplő engedélyezett és a kifizetett összegek közötti eltérések okai az alábbiak lehetnek:

- a 2018. évben megadott engedélyek számláinak egy része a 2019. évben kerültek kifizetésre, mert az engedélyező határozat kiadására a 2018. év végén került sor.
- a 2019. évben megadott engedélyek számláinak egy része pedig 2020. évben kerül kifizetésre.
- nem minden engedélyezett ellátás történt meg, a beteg állapota nem tette lehetővé az ellátás elvégzését, vagy a beteg közben elhunyt.
- a kérelmezett ellátás az engedélyező határozatban megadott érvényességi időn tt történt meg, érvényes engedélyező határozat hiányában.

A fent részletezett ellátásokon kívül több eljárással kapcsolatban kis számban érkeztek kérelmek, amelyek költségvonzata elenyésző a méltányossági kassza egészéhez képest.

Alapellátási vállalkozás-támogatási átalánydíj

A háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet tette korábban lehetővé a szolgáltatók részére történő eszköz- és ingatlantámogatás biztosítását. Ezen a címen a 2019. évben 26,6 millió forint kifizetés történt, mely kb.15,0 százalékkal kevesebb az előző évi kifizetésnél.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 32. §-a értelmében az MEP-ek által a 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az alapellátási vállalkozások támogatására kötött „Szerződés-kiegészítés”-eknek az alap- és kiegészítő támogatások folyósítására vonatkozó részei 2007. január 1-jei hatállyal megszűntek, így ettől az időponttól alap- és kiegészítő támogatás folyósítására nem került sor. A továbbiakban csak hitelintézeti kölcsön támogatás folyósítható a hitelszerződések futamidejének lejártáig.

A futamidő lejártából adódóan a támogatási szerződések száma és a finanszírozás összege 2019. évben tovább csökkent. A havi támogatás összege decemberben 2,1 millió forint volt. A szerződéskötésre jogosult háziorvosi szolgáltatók közül már senki sem rendelkezett eszköztámogatási szerződéssel, míg ingatlantámogatási szerződéssel 1,3 százalék (74 szolgáltató).

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
A Kr. 18/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a NEAK 2019. február 12-én pályázatot írt ki.

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési és praxisjog vásárlási pályázat támogatásának a célel irányzatok jogcímen belül elkülönített kerete 1250 millió forint volt, a teljesítése 1711,8 millió forint, ami szinte megegyezett a módosított előirányzattal (1711,9 millió forint).

A pályázati kiírások értelmében 2019. október 15-ig volt lehetőségük a házi- és fogorvosoknak a pályázatok benyújtására. Pályázatot nyújthatott be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység végzéséről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalta, hogy az adott házi/fogorvosi szolgálatban legalább 4, illetve 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.

Az elnyerhető támogatási összeg a háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat esetében nettó 12,0 és 20,0 millió forint között mozgott az attól függvényében, hogy mennyi ideje betöltetlen a háziorvosi/fogorvosi szolgálat. A házi orvosi praxisjog vásárlási pályázat esetében pedig maximum nettó 4,0 millió forint volt az elnyerhető támogatás. Összesen 145 pályázat érkezett az év során a NEAK-hoz: 36 házi orvosi és 30 fogorvosi letelepedési pályázat, továbbá 79 háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat. A 145 pályázatból 139 kapott nyertes minsítést. A 139 nyertes pályázóból 3 visszalépett, végül 136 orvossal (108 háziorvossal és 28 fogorvossal) került megkötésre támogatási és finanszírozási szerződés.

A háziorvosi és fogorvosi letelepedési és praxisjog vásárlási pályázat keretében végül 1711,8 millió forint támogatási összeg került kifizetésre, ebből a nyertes fogorvosi pályázók részére 648,1 millió forintot fizetett ki a NEAK. A támogatási összeg magában foglalta a nyertes pályázók részére folyósított nettó támogatási összegeken túl az ezek után fizetendő adó- és járulékterheket is.

A fogorvosi letelepedési pályázaton 2019-ben ayes-t 28 pályázó által betöltötté váló fogorvosi szolgálatok területi elhelyezkedése

A 108 szerzdött háziorvos közül 76 n és 32 férfi. Átlagos életkoruk 41,4 év, míg a jelenlegi átlagos háziorvosi életkor meghaladja az 58 évet. A 28 fogorvos közül 15 n és 13 férfi. Átlagos életkoruk 35 év, míg a jelenlegi átlagos fogorvosi életkor az 51 évnél magasabb. A pályázatok tehát jelentsen javították a korösszetételt.

A nyertesek többsége háziorvostan, vagy csecsem-gyermekgyógyászat szakvizsgával rendelkezik, de van közöttük belgyógyász, sebész, aneziológia-intenzív terápia, illetve kardiológiai szakvizsgával rendelkez orvos is.

Mentés

A mentés finanszírozására 2019. január 1-jén rendelkezésre álló költségvetési irányzat 42 930,6 millió forint volt, mely összeg az év folyamán 1283,5 millió forinttal került megemelésre. A mentés finanszírozására így a rendelkezésre álló módosított irányzattal azonos összeg 44 214,1 millió forint került kifizetésre, 449,4 millió forinttal (1,0 százalékkal) több mint az elz évben.

A beszámolással érintett id szakban a mentés kassza terhére az OMSZ és a Magyar Légiment Nonprofit Kft. mentési tevékenységét, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) szervátültetéssel kapcsolatban végzett szállítási feladatait finanszírozta a NEAK. A Magyar Légiment Nonprofit Kft. a Kr. 33/A. § (2a) bekezdése értelmében 2019-ben havi 90,0 millió forint fix összegdíjazásban részesült. Ez éves szinten 1080,0 milli forintot jelentett.

Az OVSZ szervszállítási feladatait a Kr. 33/A. § (3) bekezdése értelmében a 2018. évi összeggel azonos, havi 6,0 millió forint fix összeg az év folyamán összesen 72,0 millió forinttal finanszírozta a NEAK. A mentés kasszán maradó része, összesen 43 062,1 millió forint az OMSZ részére került kifizetésre, mely 549 millió forinttal (1,3 százalékkal) több mint a 2018-as évben.

Laboratóriumi ellátás

A labordiagnosztikai szolgáltatások 2019. évi finanszírozására 30 630,0 millió forint kifizetés történt.

A laboratóriumi ellátás finanszírozását befolyásoló jelentős jogszabályi változás 2019-ben nem volt. A teljesítményvolumen keretet továbbra is alkalmazni kellett: a labor finanszírozás szabályának értelmében a teljesítmények TVK feletti része lebegő pont-forint értékkel kerül elszámolásra. A pont-forint érték járóbeteg-szakellátással megegyezően 1,98 forint volt. A finanszírozás főbb paramétereinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

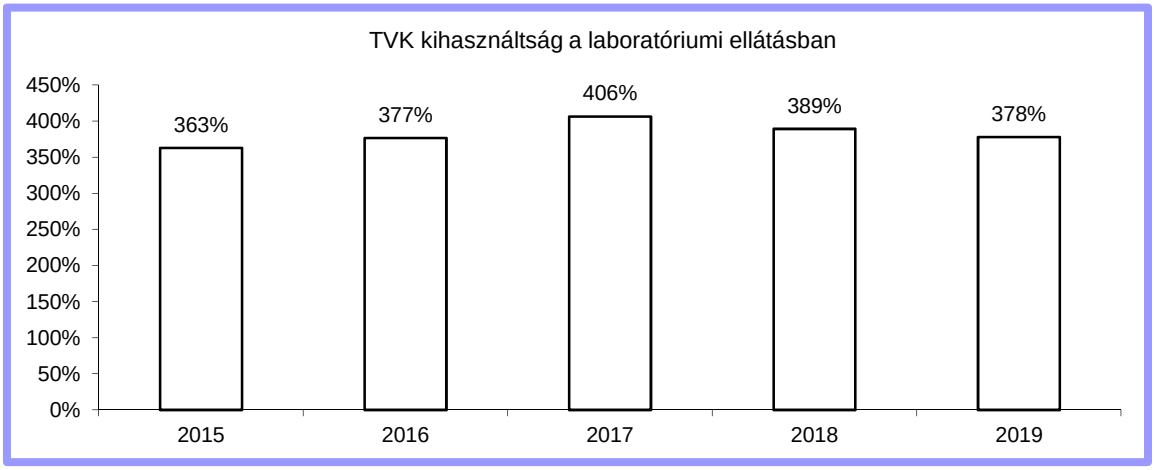
| Megnevezés | | 2018. év | 2019. év | Változás 2018-ról 2019-re |
|---|---|---|---|---|
| Beavatkozások száma | | 165 383 857 | 169 113 642 | 102.3% |
| Esetszám | | 13 840 819 | 13 926 844 | 100.6% |
| Egy esetre jutó beavatkozás | | 11.95 | 12.14 | 101.6% |
| Pont | | 34 742 850 953 | 35 863 262 214 | 103.2% |
| Egy esetre jutó pont | | 2 510 | 2 575 | 102.6% |
| Átlagos heti rendelési óra | szakorvosi | 12 365 | 12 423 | 100.5% |
| | nem szakorvosi | 8 328 | 8 381 | 100.6% |
| Egy órára jutó | eset | 12.86 | 12.87 | 100.1% |
| | beavatkozás | 153.70 | 156.32 | 101.7% |
| | pont | 32 287.42 | 33 150.56 | 102.7% |

A teljesítmény az előző évhez képest növekedést mutat, de az esetszám jellege nem változott. Továbbra is elmondható, hogy a lebegő finanszírozás egyik ismert „mellékhatása”, hogy a szolgáltatók a teljesítmény folyamatos növelésében érdekeltek: a zárt kassza miatt akkor is csökken a bevétele, ha a havi teljesítménye állandó, de a többi szolgáltató folyamatosan növeli a saját teljesítményét, mivel így az egy pontteljesítményre jutó forint összeg egyre csökken, az állandó teljesítmény egyre kevesebbet ér. Ebből adódóan a szolgáltatók egymást hajszolják bele a mind magasabb teljesítésbe.

Jelentős szerepe van annak a ténynek is, hogy a jelenlegi szabályozási környezetben a beutaló orvos sem érdekelt az indokolatlan vizsgálatok visszaszorításában. A kapacitásadatok az elmúlt két év vonatkozásában minimális változást mutatnak.

A laboratóriumi díjtételek alakulásának tendenciáját mutatja be az alábbi diagram a 2018-2019. finanszírozási év vonatkozásában.

Az alábbi ábra a laboratóriumi teljesítményvolumen keret kihasználtságát mutatja be a 2019-es és az azt megelőző években.




A számok alapján az elmúlt két évhez viszonyítva minimális csökkenés mutatható ki, de továbbra is elmondható, hogy egy labor TVK pontra három és fél - négy labor pont teljesítmény jut. A többi TVK-val finanszírozott alapellátási kassza (járóbeteg-szakellátás, aktív fekvőbeteg-szakellátás) TVK kihasználtságának adatai jóval nem rendkívül magasnak tűnnek ezek a számok.

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a TVK rendszer laboratóriumi ellátásban történő bevezetését (2006. február) követő kezdeti időszakban (a teljesítmények egy részét a szolgáltatók egy előre meghatározott, saját keret mértékéig fix – a járóbeteg-szakellátásával megegyező – forint/pont értéken számolhatják el), a laboratóriumi ellátás átlagos, egy pontra jutó forint értéke jelentősen elmaradt a járóbeteg-szakellátás forint/pont értékétől.

Kizárólag egy mesterségesen magasan tartott kihasználás (mesterségesen alacsony TVK keret) mellett lehetett a szinte változatlan nagyságú laboratóriumi irányzatból, a szintén változatlan (de inkább lassan növekvő) teljesítményt finanszírozni. A TBB keretében – a beszámolási időszakot megelőző finanszírozási évben – befogadott többletkapacitás 3 szolgáltatóval történt szerződéskötés.